המועצה המדעית ועדת הבחינות

בחינות שלב א'

רפואת המשפחה

יוני 2021

מס' השאלות בחלק זה: 150

בהצלחה!

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

1. בת 67, מתלוננת על התקפים קצרים של סחרחורת סיבובית הנמשכים עד דקה, בשבוע האחרון. לפני כחודשיים היו התקפים דומים, שחלפו מעצמם.

מהו הטיפול המשפיע על מהלך המחלה ?

א. טיפול תרופתי ב Phenergan (Promethazine) מקל ב-90% מהמקרים.

ב. טיפול ע"י Epley maneuver, מביא להקלה ב-80% מהמקרים

ג. טיפול ב-Thiazide והגבלת מלח, ימנע נזק שמיעתי לטווח ארוך .

ד. המחלה צפויה לחלוף מעצמה תוך 3-6 שבועות ולכן אין צורך בטיפול.

2. בת 21, אובחנה לפני 3 שנים עם סכרת סוג 1.

מהי הסקירה לרטינופתיה סכרתית?

א. סקירה שנתית מרגע האבחנה.

ב. סקירה 5 שנים מהאבחנה, אחת ל-5 שנים.

ג. סקירה החל מגיל 40 אחת לשנתיים.

ד. אין צורך בסקירה כעת, אלא אם יש תכנון הריון.

3. בבדיקות המעבדה של מטופלת נצפו ערכי TSH 7.3, ערכי 4T בטווח התקין. המטופלת אסימפטומטית.

באיזה מצב יש לטפל בתחליף הורמון תירוקסין?

א. אובחן פרפור עליות התקפי.

ב. המטופלת מעוניינת לרדת במשקל

ג. המטופלת הינה קשישה

ד. המטופלת מתכננת הריון

4. בן 17 שנים הופנה לבדיקות דם עקב רושם לצהבת בבדיקה גופנית. בבדיקות התקבלו התוצאות הבאות: TOTAL BILIRUBIN 2 (תקין 0.3-1.2)

DIRECT BILIRUBIN 0.2 (תקין 0.1-0.3). בדיקת שתן שלילית לבילירובין.

איזו מהבדיקות הבאות הנה הרלוונטית ביותר להמשך הבירור בשלב זה?

א. בדיקת נוגדנים להפטיטיס B, הפטיטיס C

ב. בדיקת אנזים G6PD

ג. בדיקת ANA ו ANTI-sm

ד. בדיקת GOT GPT

<u>בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021</u>

5. בת 65, סובלת ממחלת ריאות חסימתית כרונית. במהלך השנה האחרונה נזקקה בשתי פעמים לטיפול בסטרואידים סיסטמיים, ללא אשפוזים. מקבלת כעת טיפול במשאף (Anoro Ellipta umeclidinium and vilanterol). ממשיכה להתלונן על סימפטומים קלים בלבד.

על פי הנחיות GOLD מה יהווה אינדיקציה להוספת משאף סטרואידלי?

א. FEV1/FVC = 0.7 גם לאחר מתן מרחיבי סמפונות באינהלציה.

ב. FEV1 = 75% מהערך הצפוי, ללא שינוי לאחר מרחיבי סמפונות.

ג. רמת אאוזינופילים בדם מעל 300 תאים/מיקרוליטר.

ד. ערכי CRP מעל 2 (נורמה עד 0.5), ESR=30 לשעה.

6. בן 3 ימים. נולד בשבוע 39 לאחר הריון ולידה תקינים. פנה לביקורת עקב צהבת.

באיזה מקרה יש להפנותו לבירור הצהבת?

א. רמת הבילירובין הכללי הינה 10mg/dl

ב. הצהבת נצפתה לראשונה אחרי 48 שעות מהלידה.

ג. הצהבת תימשך יותר משבוע

ד. הבילירובין הכללי היה 4mg/dl ב-48 שעות ו-10mg/dl ב-72 שעות.

7. בן 80, מרותק לביתו עקב מחלת אלצהיימר, MMSE 8/30. ברקע – יתר לחץ דם. מקבל טיפול תרופתי ב-Cardiloc (Bisoprolol) ו-Spasmex (Trospium chloride). משפחתו מתלוננת על אירועים של אי שקט מוגבר לאורך היום והעדר שינה בלילה.

בבדיקתו: לחץ דם 120/70 ממ"כ, ללא ממצאים חריגים.

מהו הטיפול המומלץ ביותר בשלב זה?

א. מתן Bondormin (Brotizolam) לשעות הלילה.

ב. התחלת טיפול ב-Memorit (Donepezil).

ג. הפחתה הדרגתית בטיפול ב-Spasmex וב-Cardiloc.

ד. התחלת טיפול ב-Clopixol (Zuclopenthixol)

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

8. בן 7 שנים, יומיים טרם קבלתו ננשך על ידי כלב שידוע שהוא מחוסן לכלבת. בבדיקה הילד במצב כללי טוב. חתך באורך 4 ס"מ סמוך למפשעה ימנית עם שוליים רחבים, הפצע אדום ומפריש. בעבר הילד פיתח תפרחת בעקבות טיפול במוקסיפן. בוצע ניקוי של הפצע בתמיסת NaCl 0.9%.

באילו צעדים נוספים יש לנקוט?

א. בירור סטטוס חיסוני של הילד וטיפול פומי ב- Dalagis (Clindamycin).

ב. לקיחת תרבית מהפצע ותפירה בתפרים בודדים, המשך שטיפות בתמיסת NaCl 0.9%.

ג. קירוב שולי הפצע על ידי Steri-strip וטיפול ב- Augmentin (Amoxycillin Clavulanate).

ד. שטיפת הפצע בתמיסת NaCl 0.9% מהול ב- Rocefin (Ceftriaxone).

9. בת 31, ברקע - Crohn's Disease מאוזנת. לפני כחצי שנה אובחנה עם סוכרת וטופלה ב- Metformin ודיאטה. לאחרונה פתחה פולידיפסיה ופוליאוריה.

בבדיקתה - BMI 24 , לחץ דם – 120/80.

בבדיקות מעבדה - HBA1C 8.5%, סוכר בצום 165, פרופיל שומנים תקין.

בוצעו בדיקות דם להערכת C-peptide, ונוגדנים מסוג Antibodies to glutamic acid decarboxylase (anti-GAD), ו- Islet Cell Antibodies (ICA).

מהן התוצאות המצופות במקרה זה ?

א. C-Peptide גבוה ורמת נוגדנים נמוכה.

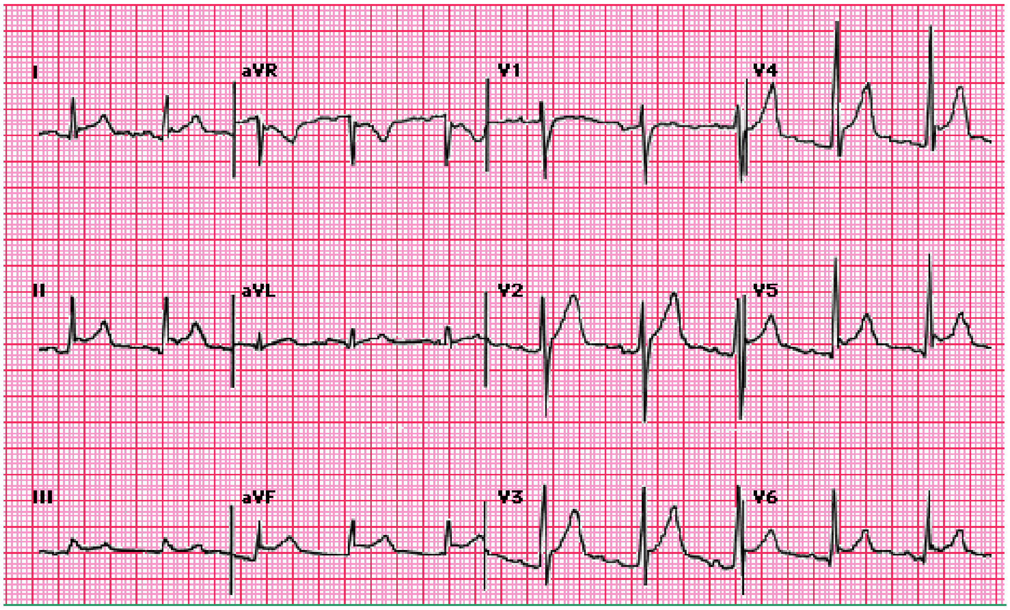
ב. C-Peptide נמוך ורמת נוגדנים גבוהה.

ג. C-Peptide גבוה ורמת נוגדנים גבוהה.

ד. C-Peptide נמוך ורמת נוגדנים נמוכה.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

10. בן 42, בריא ברקע, לפני כשבוע סבל מזיהום נשימתי. פנה עקב כאבים בחזה המוחמרים בשיעול ומוקלים ברכינה לפנים. בוצע אק"ג:



מהו הטיפול בקו ראשון למצב זה?

א. Prednisone במינון 1 מ"ג/ק"ג ליום.

ב. Methotrexate במינון 12.5 מ"ג לשבוע.

ג. Arcoxia (Etoricoxib) במינון 90 מ"ג ליום.

ד. Aspirin 100 מ"ג ליום.

11. בת 46, ללא מחלות רקע, מזה כחודש הפרשה מהפטמה השמאלית.

בבדיקתה – הפרשה חומה-דמית מהפטמה השמאלית בלבד, לא נמושו גושים או בלוטות לימפה בבתי השחי.

US שדיים וממוגרפיה תקינים. בדיקת ציטולוגיה תקינה.

מהי ההמלצה להמשך בירור?

א. US שדיים וממוגרפיה בעוד 6 חודשים.

ב. בדיקת ציטולוגיה חוזרת.

ג. רמת פרולקטין בדם.

ד. להפנות להמשך בירור בהקדם.

12. מה מאפיין את ההסתמנות הקלינית והמהלך של פיברומיאלגיה?
א. הכאב הוא כאב מוסקולוסקלטאלי כרוני ודיפוזי, הפרעה בשינה ועייפות.
ב. המהלך הקליני של המחלה הוא פרוגרסיבי, מוחמר בעונות הקיץ.
ג. הכאב האופייני בעל אופי דוקר ושורף, מחמיר בשעות הערב.
ד. התסמונת האופיינית מערבת מפרקים קטנים ומלווה בקשיון בוקר.

13. בן 15, סובל מאקנה בדרגה קלה.
מה הטיפול המומלץ?
א. Roaccutane (Isotretinoin) פומי.
ב. Minocycline פומי.
ג. משחת Acnetrim (Erythromycin).
ד. משחת Duac (Benzoyl peroxide+Clindamycin).

14. בת 23, נשואה ללא ילדים, ללא מחלות רקע וללא טיפול תרופתי. ביצעה בדיקות מעבדה מקיפות בהמלצת נטורופת. תוצאות הבדיקה תקינות פרט לרמת פרולקטין 90 ng/mL (גבוה מעל הנורמה) מציינת מחזורי וסת סדירים, ובבדיקה הגופנית - ללא ממצאים. בדיקות נוספות כולל הורמוני היפופיזה תקינות ובדיקת הריון שלילית. בוצע MRI מוח ובו תמונה המתאימה לאדנומה היפופיזרית בגודל 0.7 ס"מ.
כיצד יש להמשיך בניהול המקרה?
א. מעקב בלבד
ב. טיפול ע"י גלולות למניעת הריון
ג. מתן טיפול ב- Cabergoline (Dostinex)
ד. מתן טיפול ב- Bromocriptine(Parlodel)

15. מטופל בן 85, המתגורר במרכז סיעודי, ברקע- יתר לחץ דם, סוכרת, עודף שומנים בדם. בהערכה קוגנטיבית 15=MMSE. הבת מגיעה להתייעץ לגבי המשך הטיפול להורדת לחץ דם בגלל קשיים לתת לאב תרופות. מהי ההמלצה המתאימה ביותר לגביו?
א. היעד הטיפולי של מדידות ל"ד ביתיות הינו 150/90.
ב. למדוד בשכיבה ובעמידה בכדי לזהות מצב של אורתוסטטזים.
ג. הורדת ל"ד במטופל זה יכולה לשפר את מצבו הקוגנטיבי.
ד. בשל הסיכון הקרדיווסקולרי אין לשקול הפסקת טיפול.

16. **לפניך מספר מקרים קליניים.**

מהו המקרה שמתאים לתוצאות בדיקת ההדמיה?

א. בן 64, מעשן, פונה בשל עיוורון בעין ימין שנמשך למספר דקות וחלף. בבדיקת Trans Cranial Doppler נמצאה היצרות של 90% ב-Vertebrobasilar artery.

ב. בן 75, ברקע סכרת, פנה בשל חולשה ביד ורגל ימין שנמשכו שעתיים וחלפו. באקו לב נמצא PFO (Patent Foramen Ovale) בגודל של 0.5 מ"מ.

ג. בת 61 לוקה ביתר לחץ דם, פונה בשל סחרחורת ועיוורון בשתי העיניים, אי יציבות בהליכה שחלפה לאחר שעה. בבדיקת דופלקס נמצא היצרות של 85% בקרוטיד שמאל.

ד. בת 73, בריאה, פונה בשל הליכה על בסיס רחב, אירוע של בלבול בו לא זכרה איפה היא נמצאת. האירוע חלף לאחר 45 דקות. בהדמיה נמצא היצרות של 90% בעורק Vertebrobasilar משמאל.

17. באיזה מקרה בדיקת D-dimer תועיל ביותר לחיזוי קליני של פקקת ורידי עמוקה (DVT)?

א. בן 21, נפיחות ברגל שמאל מלווה בחום סיסטמי של 39.

ב. בן 36, לאחר טיסה שנמשכה שעתיים עם נפיחות ברגל שמאל.

ג. בת 58, לוקה בסרטן השד מפושט, עם כאב ונפיחות ברגל ימין.

ד. בת 32, בהריון שבוע 28, עם נפיחות ורגישות ברגל ימין.

18. מטופל המוכר היטב למתמחה בשלב ב' ברפואת המשפחה נבדק עקב פרכוס חדש ובהדמיה הודגמה ממאירות מוחית מפושטת מסוג Glioblastoma multiforme (GBM) שאינה ניתנת לטיפול. המטופל מסרב לפנות לייעוץ אונקולוגי ומעוניין לסיים את חייו בביתו.

מי מוסמך להגדירו כחולה נוטה למות לשם הפעלת החוק?

א. רופא מחוזי של קופת החולים המטפלת.

ב. מנהל המרפאה בה מטופל החולה.

ג. רופאו האישי של המטופל.

ד. מנהל המכון האונקולוגי של בית החולים האזורי.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

19. למרפאה מגיעים ילד בן שנתיים ואימו. האם פנתה באופן דחוף בשל הופעת שיעול נבחני, נשימה רועשת בזמן שאיפה וצרידות שהחלה בשעות האחרונות.

מה מהבאים נכון לגבי טיפול במצב זה?

א. ברובם של המקרים יש לטפל באשפוז לצורך השגחה ומתן חמצן.

ב. טיפול באדים קרים הוכח כיעיל במקרה זה.

ג. כשהגורם למחלה הינו ויראלי, טיפול בסטרואידים במתן דרך הפה הוכח כיעיל ומפחית צורך באשפוז.

ד. ניתן לתת טיפול באינהלציות אפינפרין רק בילדים מאושפזים בשל הצורך בהשגחה של יממה לפחות לאחר מתן האינהלציה.

20. בן 40, ברקע אירועים חוזרים של עווית כלייתית על רקע אבני קלציום אוקסלט.

מהי ההמלצה למטופל כמניעה שניונית במצב זה?

א. הגבלת כמות הסידן בתזונה ל-500 מ"ג ליום.

ב. הגבלת כמות הנתרן בתזונה לפחות מ-1 גר' ביום.

ג. העשרת התזונה בעלים ירוקים וסלק.

ד. תוסף מזון של Potassium citrate.

21. בן 67, מגיע עם אשתו. מתלונן על כאב ראש, כאב בטן, עייפות, קשיי שינה. אשתו מתלוננת שבחודשיים האחרונים עצבני מאד, מתפרץ בקלות. מה יתמוך באבחנה של adjustment disorder with anxiety?

א. המטופל חושש לצאת מהבית.

ב. למטופל דאגות סביב מצבו הבריאותי, הכלכלי והלימודים של ילדיו.

ג. המטופל פרש לגמלאות לפני חודשיים.

ד. המטופל מרגיש עצוב ואינו נהנה מדברים שאהב בעבר.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

22. בן 50, ברקע אלכוהוליזם. מזה מספר חודשים סובל מבצקות גומתיות דו"צ בשוקיים.
איזו בדיקה מהבאות הכי מכוונת לגורם לבצקות?
א. Negative Hepatojugular Reflex
ב. רמת Elastase נמוכה בצואה
ג. ערכי INR-0.7
ד. במיקרוסקופיה של השתן RBC Casts

23. בן 80, מתלונן על ראיה מטושטשת בעיקר כשנוהג בלילה. בבדיקתו עדשות עכורות. בבדיקת אופטיקאי שדה ראיה תקין ולא ניתן לתיקון על ידי התאמת משקפיים.
מה יכול למנוע את הדרדרות מצב זה?
א. תוספי ויטמינים.
ב. פעילות גופנית.
ג. הפסקת עישון.
ד. איזון לחץ דם וסוכר.

24. מה <u>נכון</u> לגבי אבחון ובירור כאב גב תחתון?
א. לגיל אין משמעות באבחון כאב גב תחתון.
ב. הקרנה לרגל מחייבת בירור הדמייתי.
ג. גורמים פסיכוסוציאלים אינם משפיעים על עוצמת הכאבים.
ד. חום מהווה דגל אדום.

25. בן 25, בריא בד"כ, מעשן כקופסה ביום. מגיע למרפאה בתלונה של שיעול וחום 38.5. בבדיקתו - נינוח נשימתית, סטורציה 98%, דופק 95, חום 37.8, בהאזנה לריאות - קראפיטציות בבסיס השמאלי, בצילום חזה - תסנין בLLL.
מה ההסבר הנכון ביותר למטופל בביקור הנוכחי?
א. השיעול והחולשה משתפרים כשבוע אחרי סיום הטיפול.
ב. מומלץ טיפול אמפירי קצר של 5 עד 7 ימים באנטיביוטיקה.
ג. ניתן להשהות החלטה לגבי טיפול אנטיביוטי ל-48 שעות, ולטפל אם אין שיפור.
ד. אזמין את המטופל בעוד כחודש לשיחה על הפסקת עישון.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

26. בן 4, אבני דרך התפתחותיות תקינות, עם פרכוסי חום בעבר. לאחיו היו פרכוסי חום עד גיל 5. לפני יומיים החלה מחלת חום עם פרכוס כללי טוני-קלוני, ולאחר 10 שעות הופיע פרכוס נוסף, נמשך 20 דקות, מלווה בסימנים פוקאליים.

מה מגביר את הסיכוי להתפתחות אפילפסיה בעתיד?

א. הפרכוס הנוכחי הוא פרכוס פוקאלי.

ב. סיפור משפחתי של פרכוסי חום

ג. אירועים חוזרים של פרכוסי חום

ד. המשך הפרכוס עד גיל 4

27. בת 38, מזה מספר שנים סובלת מכאבי אגן קשים לסירוגין ובזמן קיום יחסי מין. בדיקה גופנית ובדיקות דם תקינות. בלפרוסקופיה אובחנה Endometriosis .

מהו הטיפול שיתרום להפחתת הכאבים ?

א. שימוש בהתקן תוך רחמי מנחושת (לא הורמונלי) מסייע בהפחתת הכאב באגן.

ב. כריתה ניתוחית לפרוסקופית של הנגעים יכולה לסייע להפחתת הכאב באגן.

ג. גלולות למניעת הריון יעילות בהפחתת הכאב בכל שלבי המחזור החודשי.

ד. טיפול בנוגדי דיכאון טריציקליים הינו יעיל בהפחתת כאב אגן באנדומטריוזיס.

28. למרפאה מגיעה ילדה שאינה מוכנה להזיז את מרפק ימין. ההורה מספר שבזמן פעילות במוסד החינוכי יד ימין שלה נמשכה ומאז אינה מוכנה להזיז את היד.

מה מהממצאים הבאים תומך באבחנה של מרפק משוך (Pulled Elbow)?

א. הילדה בת 6 שנים.

ב. בצילום נמצא שבר סופראקונדילרי בהומרוס ימני.

ג. הילדה מסרבת לקפל וליישר את המרפק אך מסכימה לבצע סופינציה.

ד. במישוש של המרפק הימני <u>לא</u> נמצא נפיחות פירקית.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

29. בן 82, צלול ועצמאי עד כה. הגיע למרפאה בלוויית בנו שמספר כי מזה יומיים מבולבל, סובל מאי-שקט ובריחת שתן שלא הייתה קודם לכן. בבדיקה גופנית – ללא כל ממצא מכוון.

מהו השלב הבא בבירור?

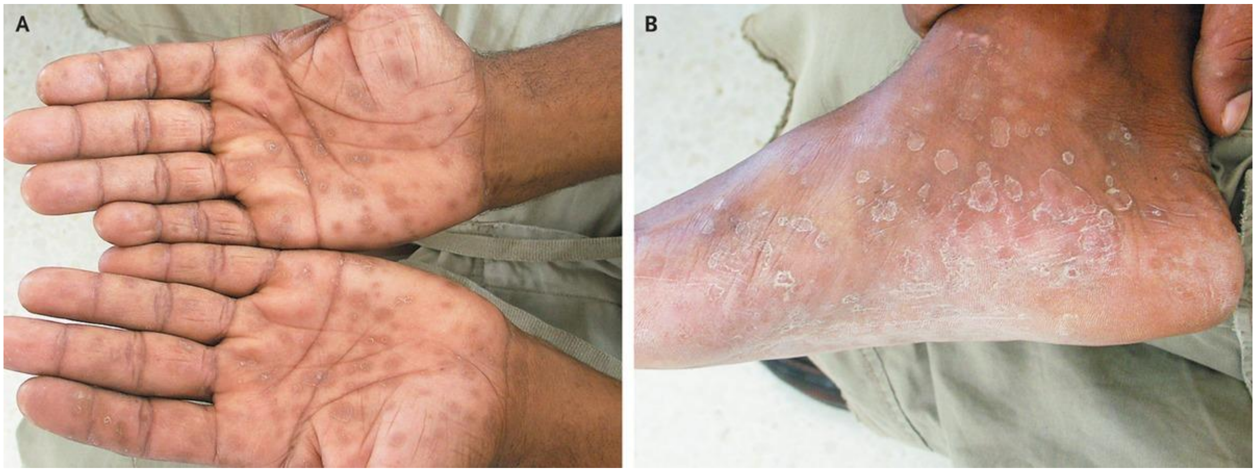
א. הפניה דחופה למרפאה גריאטרית, להערכה בשל ירידה קוגניטיבית חדשה.

ב. בדיקת שתן וצילום חזה בהקדם בחשד לזיהום.

ג. CT מח דחוף בשאלה של אירוע מוחי או תהליך-תופס מקום.

ד. הפניה לנוירולוג בשאלה של (NPH (normal pressure hydrocephalus.

30. בת 32, בריאה, בעברה פיתחה תפרחת בעקבות טיפול ב-(Moxypen (Amoxycillin. בהריון שבוע 28, מקיימת יחסי מין מזדמנים, ללא בן זוג קבוע. בשבועיים האחרונים סובלת מתפרחת על פני הגוף כולל כפות ידיים ורגליים (ראה תמונה המצורפת). תפרחת אינה מגרדת ואינה כואבת.



איזה טיפול נדרש?

א. (Doxylin (Doxycycline פעמיים ביום במשך 14 יום.

ב. (Azenil (Azithromycin 2 גרם חד פעמי.

ג. Benzathine penicillin עם דהסנסיטיזציה.

ד. (Rocephin (Ceftriaxone 250 מ"ג IM עם Azenil 1 גר' חד פעמי.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

31. 50 מטופלים אשר אובחנו בבדיקת PCR כחיוביים לקורונה הסכימו להשתתף בניסוי לבחינת הרגישות של בדיקה מהירה חדשה. הבדיקה הניסיונית לא הצליחה לגלות 10 מתוכם.

מהי רגישות הבדיקה החדשה?

א. הרגישות הינה 20%

ב. הרגישות הינה 40%

ג. אין מספיק נתונים לקבוע

ד. הרגישות הינה 80%

32. נערה בת 16, בריאה ברקע, מתלוננת על כאב ראש.

באיזה מקרה יש צורך להמשך אבחון ע"י הדמיה?

א. במשפחה מספר מבוגרים הסובלים ממיגרנות באופן קבוע.

ב. כאב ראש בשעת היקיצה בבוקר החולף בקימה מהמיטה.

ג. כאב מצחי בעת התקף כאב הראש.

ד. מתארת אאורה ויזואלית לפני תחילת הכאב

33. בת 14, סובלת מאירועים חוזרים של בחילה והקאה, מלווים באי נוחות בבטן. מציינת תחושת עקצוצים בשפתיים ונפיחות קלה בכפות הידיים בזמן ההתקף. מספר אירועים נצפו עוד בילדות המוקדמת, התדירות גברה בשנה אחרונה. הבירור שעברה כלל גסטרוסקופיה וקולונוסקופיה שהיו תקינות, ובדיקה גנטית ל-FMF הייתה שלילית.

איזו בדיקה תכוון באופן טוב ביותר לאבחון מצבה של המטופלת?

א. רמת C1 Inhibitor

ב. רמת C3

ג. סרולוגיה לצליאק

ד. Antinuclear antibody

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

34. באיזה מהמקרים הבאים נדרש להוסיף/להתחיל טיפול תרופתי לאיזון יתר לחץ דם?

א. בן 85, צלול, רקע של סוכרת, אוסטאופורוזיס ושנתיים לאחר שבר בצוואר הירך, יל"ד מטופל תרופתית בשתי תרופות, לחצי דם ממוצעים 140/90.

ב. בן 35, מזה שנה במעקב בגלל ערכים ממוצעים של 145/90, ירד במשקל באמצעות ספורט ותזונה ובביקור האחרון ערכים במדידות ביתיות 141/90.

ג. בן 70, בריא, ללא טיפול קבוע, מספר מדידות חוזרות במרפאה בחודש האחרון של 140/90. המטופל מתעקש שאינו מעוניין בתרופות אלא לנסות שינוי באורחות חיים.

ד. בת 69, יל"ד ידוע מזה 5 שנים, מטופלת בשילוב של שתי תרופות לאיזון ל"ד, ערכים ממוצעים שנמדדים במרפאה 130/80.

35. בן 78 הנמצא בטיפולך הקבוע. ברקע ידוע על יתר לחץ דם, סכרת, ומחלת לב איסכמית. לאחרונה מספר אירועים של חולשה ואיבוד הכרה קצר. בברור קרדיאלי אירועים קצרים של ברדיקרדיה קיצונית, דופק 30. הוא מיועד לטיפול במרפאת קוצבים.

מה ההנחיה למטופל זה לגבי נהיגה?

א. להפסיק לנהוג כי בנהיגה הוא מסתכן ומסכן, לעדכן אותו כי עלי ליידע המרב"ד וכי יוזמן להיבדק שם לגבי כושר נהיגתו.

ב. בשלב זה נמצא בבירור ולכן רק אחרי הסיום יש להתייעץ עם קרדיולוג.

ג. כיום אין צורך לעשות דבר, אך כשיביא "טופס ירוק" לחידוש רישיון יש לציין בו על נושא הפרעות הקצב.

ד. לטלפן למשרד התחבורה, לפי הנוהל, ולהודיע להם להפסיק את נהיגתו באופן מידי.

36. בן 9, נבדק עקב מחלה וירלית בדרכי הנשימה העליונות , ההורים בצעו על דעת עצמם משטח מהיר לסטרפטוקוקים שהיה חיובי ובעקבות כך החלו טיפול ב- Moxypen (Amoxycillin) שהיה ברשותם. שבוע לאחר תום הטיפול בוצע משטח גרון והתקבלה תשובה חיובית ל-GAS.

באיזה מקרה יש לשקול טיפול, ומהו הטיפול המתאים?

א. בעבר אובחן - Post streptococcal glomerulonephritis, טיפול ב-Rafapen (penicillin VK) למשך 3 שבועות.

ב. סבתו של הילד מתגוררת אתם בבית וסובלת מדיכוי חיסוני משמעותי, טיפול ב-Azenil (Azithromycin) למשך שבוע.

ג. לאחותו היסטוריה של acute rheumatic fever, טיפול ב- Clindamycin (Dalacin) למשך 10 ימים.

ד. הילד מאובחן כסובל מדלקת פרקים כרונית ומקבל טיפול אימונוסופרסיבי, טיפול ב- Clindamycin למשך שבועיים.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

37. אישה בשבוע 9 (3+) להריונה, מתלוננת על בחילה והקאה שהחלו לפני שבועיים והחמירו לאחרונה. בבדיקה – לחץ דם 99/66 ממ"כ, דופק 86, חום 36.9 מ"צ, ללא רגישות בטנית וללא סימני גירוי צפקי. שתן בסטיק – משקל סגולי 1.010, ללא קטונים. ניסיון לטפל בשינוי תזונתי ו- OTC המכיל ויטמין B6 וג'נג'ר הביאו לשיפור חלקי בלבד.

מהו הטיפול המומלץ בשלב זה?

א. מתן נוזלים NaCL 0.9%.

ב. להוסיף לטיפול הקיים Doxylamine.

ג. מתן Zofran (Ondasetron) עד פעמיים ביום.

ד. להפנות לדיקור סיני.

38. מטופל עשיר סובל ממאירות ריאות מפושטת ולכן מינה את אשתו למיופת כוח על פי חוק החולה נוטה למות. עקב זיהום בדרכי השתן נתון למצב בלבולי. בהיותו לא כשיר לקבל החלטה אשתו נתנה הוראה להימנע מכל טיפול. אתה מתרשם שפועלת מרדיפת בצע ולא מתוך דאגה לבעלה העשיר.

כיצד על הרופא המטפל לנהוג?

א. האישה נבחרה כמיופת הכוח – יש לציית להנחיותיה.

ב. האישה אינה פועלת לטובתו - יש להתעלם מהנחיותיה.

ג. יש לפנות לוועדה מוסדית.

ד. יש להתייעץ עם הרופא האחראי.

39. בן 50 נפל לפני כשבועיים ושבר את קרסול ימין. הרגל נותחה וגובסה וכעת נמנע מלדרוך על הרגל, נעזר בקביים. מתלונן על חולשה של יד ימין, מרגיש כאילו משותקת. בבדיקה – חולשה של שרירים אקסטנסורים לכל אורך יד ימין.

מהי האבחנה הסבירה ביותר?

א. תהליך מרכזי במוח מאחר ויש מעורבות של יד ורגל מימין.

ב. Carpal tunnel syndrome מימין.

ג. שבר ב-Ulna ביד ימין שלא אובחן אחרי הנפילה.

ד. Radial nerve injury.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

40. בת 38, בריאה בד"כ, ללא טיפול תרופתי קבוע, לא מעשנת, ללא אלרגיות ידועות. מתלוננת על נזלת מוגלתית, שיעול קל, כאב ראש מזה 4 ימים. בבדיקתה במצב כללי טוב, מדדים חיוניים תקינים, ראות נקיות, רגישות בניקוש הסינוסים הפרונטליים.

מהו הטיפול המומלץ במקרה זה?

א. Augmentin ותרסיס סטרואידים.

ב. אנטי-היסטמינים פומי.

ג. Prednisone דרך הפה.

ד. שטיפות אף עם מי מלח, מפיגי גודש.

41. בבדיקת על שמע של בן 65 נמצאה הרחבה של אבי העורקים הביטני לקוטר של 4.5 ס"מ.

מהי ההמלצה המתאימה ביותר?

א. מעקב אחת לחצי שנה אחר קוטר המפרצת.

ב. הורדת לחץ דם ליעד של 120/80.

ג. הפניה לניתוח תיקון מפרצת בהקדם.

ד. טיפול בנוגדי טסיות באופן קבוע.

42. בת 75, בשבועות האחרונים סובלת מכאבים בשכמות וחולשה כללית. בבדיקות המעבדה: שקיעת דם 80 לשעה ואנמיה נורמוציטית נורמוכרומית. פנתה כי מהבוקר חשה כאב ראש חד צדדי מלווה בירידה חדה בראיה וקושי בתנועות גלגל העין באותו צד. מהו הטיפול המיידי?

א. מתן Imitrex (Sumatriptan) 50 mg.

ב. כיסוי העין בחבישה לוחצת והפנייה למומחה עיניים.

ג. מתן Prednisone 60 mg במרפאה והפניה למיון.

ד. שטיפת העין בשני ליטרים של מים והפניה למיון עיניים.

43. בן 50 מתלונן על כאב בזרוע ימין בתנוחות מסוימות, ירידה בתחושה וחולשה באצבעות 4,5 ביד ימין ושינוי צבע של היד. בבדיקתו – רפלקסים תקינים.

מהי האבחנה המתאימה ביותר?

א. Toracic Outlet Syndrome.

ב. Carpal Tunnel Syndrome.

ג. Reynaud Phenomena.

ד. Cervical Radiculopathy.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

44. מה מגביר את הסיכון לפתח סוכרת הריונית?

א. הסיכון גבוה יותר בנשים צעירות

ב. ירידה מהירה במשקלה של האישה מעלה את הסיכון

ג. מקרוזומיה (ללא סכרת הריונית) בהריון קודם מעלה את הסיכון

ד. מום פתוח בתעלה העצבית בהריון קודם מעלה את הסיכון בעתיד

45. בן 55, עבר לאחרונה התקף לב . עישון של 20 סיגריות ליום מגיל 16.
בעקבות התקף הלב צמצם עישון ל-7 סיגריות ליום במשך שבועיים, אולם בעקבות משבר משפחתי חזר לעשן כהרגלו.

לפי המודל של פרוצ'סקה- Stage of change model באיזה שלב נמצא המטופל?

א. Precontemplation

ב. Contemplation

ג. Preparation

ד. Action

46. בת 76, ברקע - דכאון, גלאוקומה וכאבי גב כרוניים. מטופלת ב-Lustral (Sertraline) ו- Tramadol.
מלפני כחודשיים סבלה משלבקת חוגרת ב-T4 ומאז סובלת מכאבים נוירופטיים.

מה הטיפול המתאים ביותר לכאב הנוירופטי?

א. Cymbalta (Duloxetine)

ב. Remotiv (Hypericum)

ג. Elatrolet (Amitriptyline)

ד. Cream Capsaicin (Zostrix)

47. תינוק בן 5 חודשים נבדק בבדיקה תקופתית, אשך ימין לא נמוש בשק האשכים, ההורים חוששים מבצוע ניתוח.

מהו ההסבר להורים לגבי הצורך בניתוח?

א. מומלץ לעבור ניתוח להורדת האשך לשק האשכים בגיל שנתיים.

ב. לאחר הניתוח אין סיכון יתר לחלות בסרטן האשכים.

ג. לאחר גיל ארבעה חודשים האשך אינו חוזר ספונטנית למקומו.

ד. רק 50% מהילדים עם אשך טמיר אחד שמנותחים בזמן נותרים פוריים.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

48. בן 70, סובל מעודף משקל, סכרת, יתר לחץ דם, עבר זיהום בדרכי השתן לאחרונה. לפני 3 שנים עבר החלפת פרק ירך ימין.

במשפחתו לאחיו יש Ankylosing Spondylitis.

לאחרונה מתלונן על כאבים חדשים בירך זו, בצילום התרופפות של השתל.

מה יכול להסביר את מצבו ?

א. Osteoarthritis חוזרת בירך זו על רקע גורמי הסיכון שלו.

ב. Septic Arthritis על רקע התפשטות המטולוגית מזיהום בדרכי השתן.

ג. Pseudogout המתפתח כתוצאה מהתרופפות השתל.

ד. תסמין ראשון של Ankylosing Spondylitis לאור הסיפור המשפחתי.

49. באיזה מהמצבים הבאים מבחן מאמץ הוא הבדיקה המועדפת להמשך הבירור?

א. בן 42, אסימפטומטי, ללא גורמי סיכון, מעוניין בבדיקת סקירה עקב דאגות בריאות.

ב. בת 50 עם גורמי סיכון למחלת לב, מתלוננת על דקירות בחזה בחצי שנה אחרונה ללא קשר ברור למאמץ. לפני שנתיים עברה מבחן מאמץ שהראה צניחות ST-T עמוקות חשודות לאיסכמיה לכן בוצע בהמשך מיפוי טליום שפורש כתקין.

ג. בת 64 ,לאחר אוטם שריר הלב לפני 3 שנים עם הכנסת תומכן לעורק PROX LAD, מאז אסימפטומטית עד לפני שבועיים . בשבועיים אחרונים 4 אירועים של כאבים שורפים בחזה בזמן הליכה חולפים תוך 5 דקות במנוחה, אירוע אחרון של כאבים לפני יומיים הופיע במנוחה.

ד. בן 47, לאחר אוטם שריר הלב עם הכנסת תומכן לעורק RCA לפני חודש, מרגיש טוב, ללא הגבלה בפעילות יום יומית, מבקש להעריך אפשרות של חזרה לעבודה פיזית.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

50. מחקר בדק האם שימוש בתוסף אבקת חלבון בקרב ספורטאים מעלה את רמת הקראטינין בדם. נמצא, כי רמת הקראטינין הממוצעת בקרב קבוצת הניסוי הייתה mg/dl1.1 כאשר רווח בר סמך (Confidence Interval) 95% היה 0.9-1.3 mg/dl.

מה מהבאים נכון לגבי רווח בר סמך לערך הקראטינין?

א. הגדלת המדגם הייתה מגדילה את הרווח בר סמך.

ב. מכיוון ורווח בר סמך חוצה את הערך 1 אין להסיק ממנו מסקנות במקרה זה, הוא אינו משמעותי סטטיסטית.

ג. ניתן להסיק בסבירות של 95% כי ערך הקראטינין הממוצע האמיתי באוכלוסייה ממנה נלקחו הנדגמים הינו בין 0.9 ל1.3 mg/dl

ד. ככל שהשונות (variability) של הערך הנבדק בין המשתתפים גבוהה כך הרווח בר סמך יהיה צר יותר.

51. למרפאה נכנסת אם מבוהלת נושאת את ביתה בת השנה בזרועותיה ומתארת שבזמן התקף של בכי עקב לקיחת צעצוע הפסיקה לנשום והכחילה. חזרה להתנהג כרגיל תוך כדקה.

איזה מהמצבים קשור עם הסיטואציה המתוארת?

א. עלייה בסיכון לפתח הפרעות פרכוסיות בעתיד.

ב. מחסור בברזל לעיתים עד כדי אנמיה.

ג. קיום נגע במערכת העצבים המרכזית.

ד. הפרעת קצב קרדיאלית.

52. נערה בריאה בת 16.5 מגיעה בלוויית אמה. מציינת איחור בווסת של - 5 שבועות. בדיקת הריון ביתית חיובית פעמיים. מקיימת יחסים בלתי מוגנים עם פרטנר קבוע. אינן מעוניינות בשימור ההיריון.

מהי ההמלצה לגבי הפסקת הריון תרופתית ?

א. ניתן לתת מרשם ל Mifepristone 600 מ"ג וביקורת רופא נשים תוך 3 ימים מנטילת הכדורים.

ב. ניתן לתת מרשם ל-Levonorgestrel 1.5 mcg (Postinor) וביקורת רופא נשים תוך 3 ימים מנטילת הכדורים.

ג. האפקטיביות של הפלה תרופתית בטרימסטר ראשון גבוהה, אך משבוע 9 פוחתת בכ-5%.

ד. שיעור הסיבוכים בהפלה כירורגית בטרימסטר ראשון כפול מאשר בהפלה תרופתית.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

53. איזה גורם מהבאים מעלה את הסיכון לסרטן הקיבה?

א. שימוש ממושך ב-Proton pump inhibitors.

ב. שימוש ממושך ב-H_2 blockers.

ג. צריכת אלכוהול מוגברת.

ד. צריכת מלח מוגברת.

54. בת 68, ברקע GERD קשה, אוסטאופורוזיס מטופלת ב-ACLASTA פעם בשנה דרך הווריד מזה 3 שנים, אינה מעשנת, ללא היסטוריה של שברים בעברה, בבדיקת DEXA עדכנית לעומת לפני שלוש שנים:

	2020	2017
מפרק הירך מצד ימין	-1.5	-2.5
מפרק הירך מצד שמאל	-1.4	-2.4
עמוד השדרה	-1.5	-2.8

מהו המשך הטיפול המתאים?

א. טיפול ב ACLASTA לעוד שנתיים ובדיקת DEXA חוזרת בעוד שנתיים.

ב. טיפול ב- ACLASTA למשך כל חייה הפסקת הטיפול עלולה לעלות את הסיכוי לשברים רבים בעמוד השדרה.

ג. הפסקת הטיפול ב-ACLASTA , ומעבר לטיפול בביספוספונטים פומיים.

ד. הפסקת הטיפול ב- ACLASTA, ההשפעה של הטיפול תמשך לעוד שנים נוספות.

55. בת 30, הגיעה כעת לראשונה למרפאתך. בילדותה vesicoureteral reflux שלא טופל בזמן, וכתוצאה מכך אי ספיקת כליות כרונית, קריאטינין בסיס 1.5 eGFR 65 (CKD stage 2).

איזו מהבדיקות יש לבצע כמעקב בשלב זה?

א. ויטמין D

ב. כולסטרול

ג. TSH

ד. איסוף שתן לחלבון

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

56. בת 31 בהריונה הראשון, שבוע 27. ב-3 שבועות אחרונים ל"ד סביב 145/93. ללא כאבי ראש, ללא בצקות, סטיק שתן לחלבון שלילי. בדיקות מעבדה רחבות תקינות. במדידה במרפאה ערכים דומים.

מהי ההמלצה למטופלת ?

א. הגבלה בפעילות גופנית.

ב. דיאטה דלת מלח.

ג. ירידה במשקל.

ד. מתן תוספת סידן .

57. בן 9**,** לדברי המורה הוכש ביד שמאל על ידי נחש לא מזוהה. בבדיקה נראה סימן הכשה, נפיחות ניכרת ביד ושטף דם סביב פצע ההכשה.

בזמן ההמתנה לאמבולנס שייקח אותו לחדר מיון מה ניתן לעשות במרפאה?

א. הנחת קרח סמוך למקום הנשיכה.

ב. בצוע חסם ורידי פרוקסימלית למקום הנשיכה.

ג. שימוש ב-Suction על מיטת הפצע להוצאת הארס (venom).

ד. הורדת שעון/צמיד הנמצאים פרוקסימלית לנשיכה.

58. בת 55, לוקה בסכרת, מזה כ-3 חודשים כאבים בכתף ימין, והגבלה בהרמת היד. ללא סיפור של חבלה, נפילה או פעילות גופנית חריגה.

מה יתמוך באבחנה של adhesive capsulitis?

א. הגבלה בהרמה פסיבית של יד ימין.

ב. חסר תחושתי בכף יד ימין.

ג. Neer test חיובי מימין.

ד. כאב מופק בזמן שמנסה לגעת עם יד ימין בכתף שמאל.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

59. בת 40 חזרה מטיול בחוף המזרחי של ארה"ב. מתלוננת על שיתוק של עצב הפנים מימין. מציינת שסבלה גם מכאב ראש ותפרחת על זרוע שמאל לפני כשבוע ומציגה צילום של התפרחת:

מהו הטיפול המתאים ביותר במקרה זה?

א. Prednisone 40 מ"ג לשבוע.

ב. Doxylin (Doxycycline) 100 מ"ג פעמיים ביום לשבועיים.

ג. Benzathine penicillin 2.4 מיליון יחידות תוך שרירי פעם בשבוע ל-3 שבועות.

ד. Pentostam (Sodium stibogluconate) 100 מ"ג פעם ביומיים, שלוש מנות.

60. בת 52, עברה כריתת רחם בגיל 40 עקב שרירנים מרובים. מתלוננת על גלי חום, חוסר שינה, יובש בנרתיק וכאב במגע מיני.

מהו הטיפול הטוב ביותר עבור המטופלת?

א. טיפול הורמונאלי משולב אסטרוגן ופרוגסטרון לפרק זמן מוגבל.

ב. טיפול ב- SSRI במינון נמוך ותכשיר אסטרוגן נרתיקי.

ג. תוספת Cimidona (Black Cohosh).

ד. טיפול ב-(Clonnirit (Clonidine.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

61. בת 79, אלמנה וגרה לבד. ילדיה גרים בעיר אחרת. בביקור בית , ביתה מאד לא מסודר, מוזנח ומלוכלך. MMSE 25/28. היא עצמאית בטיפול האישי. האישה עונה שאין לה כוח לנקות את ביתה בעצמה ואין לה כסף לעוזרת.

מהי ההמלצה שתסייע לה ?

א. להפנות אותה ללשכת רווחה וליזום פגישה עם ילדיה.
ב. לדווח ללשכת רווחה בחשד להזנחה של קשיש.
ג. ליצור קשר טלפוני עם ילדיה ולהסביר להם את הצורך בסידור הבית.
ד. להפנות לביטוח לאומי לקבלת "חוק ביטוח סיעוד" עבור הגברת.

62. בת 32 מדווחת על ירידה לא רצונית של 10 ק"ג בשנה האחרונה. בבדיקה הגופנית ניכרת לימפאדנופתיה מפושטת בבתי שחי, מפשעות, צוואר.

מה מומלץ כחלק מהמשך הבירור ?

א. בדיקות למרקרים CA19-9 CA125 CA15-3 CEA
ב. FNA מבלוטה נגישה
ג. סונר בטן ואגן
ד. סרולוגיה ל-HIV

63. מבין המטופלים הבאים הסובלים מסוכרת לא מאוזנת שנים רבות למי הסיכון הגבוה ביותר לפתח רטינופתיה סוכרתית?

א. מטופל עם מחלת לב איסכמית.
ב. תת פעילות של בלוטית התריס לא מאוזנת.
ג. עישון מעל 10 סיגריות ליום.
ד. מטופל עם ממאירות של המעי הגס.

64. בת 55, אתמול כשירדה במדרגות עיקמה את הקרסול. בכניסתה כעת לחדרך היא צולעת.

מה יסייע להעריך את מידת הנזק לרצועות הקרסול?

א. מבחן מגירה ו- Talar test.
ב. פרטים לגבי גובה ומהירות הנפילה.
ג. הערכת מחלות רקע וסיכון לאוסטאופורוזיס.
ד. מידת הנפיחות וקיום שטף דם בקרסול.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

65. בת 55 אובחנה עם סרטן ריאה בעקבות שיעול ממושך. בCT נראה גוש בקוטר כ3 ס"מ במיקום פריפרי. המטופלת הוזמנה לביופסיה. היא חוששת מאד מהפרוצדורה, ומרגישה שאין בה טעם, כיוון שמדובר במחלה עם פרוגנוזה קשה בכל מקרה.

מה תסביר למטופלת?

מהי הסבה לצורך לקבל אבחנה היסטולוגית ?

א. קיים סיכוי של 50% לריפוי ע"י שילוב של ניתוח וכימותרפיה, ולכן יש חשיבות לקבל דגימה מהגידול.

ב. באדנוקרצינומה של הריאה, סמנים מולקולריים ברקמת הגידול עשויים לשפר את בחירת הטיפול ואת הפרוגנוזה.

ג. סמנים מולקולריים ברקמת הגידול עשויים להשפיע על ההחלטה האם יש צורך בקרינה.

ד. מיקום פריפרי אופייני לNSCLC, גידול עם פרוגנוזה פחות טובה, ואבחנה רקמתית לא תשפיע על בחירת הטיפול.

66. בן שנתיים בריא בד"כ, מחוסן בהתאם לגילו. הגיע עקב שלשול שהחל יממה קודם. כ-3-4 יציאות מימיות ליום. נותן מעט פחות שתן מהרגיל. בבדיקתו - טורגור מעט ירוד, שאר הבדיקה הגופנית תקינה, מדדים חיוניים תקינים.

מהו הניהול במקרה זה?

א. אשפוז לצורך מתן נוזלים תוך ורידי.

ב. בדיקת אלקטרוליטים וטיפול בהתאם.

ג. בדיקת תרבית צואה וטיפול אנטיביוטי בהתאם.

ד. מתן Oral Rehydration Solution ושקילת פרוביוטיקה.

67. לפניך תיאור של 4 מטופלים שמעוניינים בתרופה טבעית (herbal supplement) לבעייתם.

למי מהם ניתן להמליץ על טיפול טבעי?

א. בן 70, סובל ממחלת לב איסכמית, הוכנת תומכן (Stent) ל-LAD לפני 4 חודשים, מתלונן על ירידה קוגניטיבית ומבקש Ginkgo Biloba.

ב. בן 30, בהליכי גירושים, מאד מתוח, סובל מאסטמה, מבקש Kava-Kava.

ג. בן 40, לאחר החלפת מסתם מיטרלי למסתם תותב, מתלונן על דיכאון, מבקש St.John’s wort (Hypericum perforatum).

ד. בן 15, השמין לאחרונה, התחיל פעילות גופנית מאומצת, מבקש Ephedra לעזור לירידה במשקל ושיפור הכושר.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

68. בת 30, נשואה ואם לילד, בריאה, גילתה שהיא בהריון בלתי מתוכנן. מעוניינת להפסיק את ההיריון.
מה אומר החוק בנושא של הפסקת הריון?
א. ניתן לאשר הפסקת הריון מחמת גילה של המטופלת.
ב. הוועדה חייבת לקבל הסכמת הבעל להפסקת הריון.
ג. ניתן להפנות לוועדה להפסקת הריון רק לאחר הוכחת קיום מומים אצל עובר.
ד. הוועדה רשאית לאשר הפסקת היריון אם יוכח שההיריון עלול לפגוע בבריאותה הנפשית של המטופלת.

69. בת 8 שנים, חוזרת לבית הספר לאחר שהייתה חולה בבית במשך שבוע ימים. הוריה נמצאים בתהליך גירושין. כעת חוששת לחזור לביה"ס עקב פחד כי יקרה משהו לאביה. מתקשה להירדם בלילה כאשר לבדה וחולמת בלילות חלומות בלהה (Night Mares) בהם הוריה מתגרשים.
מהי האבחנה הסבירה?
א. Depressive disorder
ב. Generalized anxiety disorder
ג. Normal reaction to divorce
ד. Separation anxiety

70. מטופלת בת 30 מתלוננת על רעד.
מה יתמוך באבחנה של ESSENTIAL TREMOR?
א. הרעד התחיל באופן פתאומי בימים האחרונים
ב. הרעד מחמיר בשתיית אלכוהול
ג. אבא של המטופלת סובל מרעד בראש
ד. הרעד מופיע בעיקר כשהידיים במנוחה ומונחות על השולחן

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

71. בת 41, ברקע השמנת יתר (BMI 36), בהריון ראשון, שבוע 35, במעקב מרפאת הריון, עד כה תקין. פנתה למרפאה בשל בצקות בגפיים דו"צ שהתפתחו ביומיים האחרונים. בבדיקתה: לחץ דם 142/80 ממ"כ, דופק 90 לדקה, במדידה נוספת כעבור שעה 145/82, בצקות בגפיים +2 דו"צ, פרט לכך ללא ממצאים חריגים. בבדיקות דם שביצעה אתמול:

המוגלובין 12.8

טסיות 94,000

11,000 WBC

קריאטינין 0.9

88 ALT

כיצד יש להתקדם באבחנה ובטיפול?

א. ניטור לחץ דם, ניטור מעבדתי ופרופיל ביופיסיקלי פעם-פעמיים בשבוע.

ב. מתן Magnesium sulfate, טיפול להורדת לחץ דם והחלטה על יילוד באשפוז.

ג. טיפול ב- Labetalol 200 מ"ג ליום, Acetylsalicylic Acid 75 מ"ג ליום, תוך ניתור לחץ דם, מעקב מעבדתי וביופיסיקלי פעם-פעמיים בשבוע.

ד. הפניה לחדר לידה לצורך יילוד מיידי.

72. בן 55, סובל מפסוריאזיס. עד כה מחלתו נשלטה בשימוש משחות מקומיות. בשנה אחרונה התחיל טיפול ליתר לחץ דם ראשוני. מתלונן על החמרה של פסוריאזיס.

מי מבין התרופות עלולה לגרום להחמרה זו?

א. Norvasc (Amlodipine)

ב. Normiten (Atenolol)

ג. Clonnirit (Clonidine)

ד. Tritace (Ramipril)

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

73. בן 50, ללא מחלות רקע, סובל משלשול מזה 9 ימים. משלשל כ-4-6 פעמים ביום, ללא דם או ריר, ללא חום סיסטמי גבוה. בדיקתו הגופנית תקינה.

מה הגישה האבחנתית במקרה זה?

א. תרבית צואה.

ב. צואה לפרזיטים.

ג. ספירת דם ובדיקה סרולוגית לצליאק.

ד. לא נדרש בירור בשלב זה.

74. על פי הנחיות ADA משנת 2020 באיזה מקרה יש לבצע בדיקות סקירה לאבחון טרום סוכרת ?

א. בת 29, היקף מותניים 75 ס"מ, נולדה במשקל 4 ק"ג, ללא סיפור משפחתי של סוכרת.

ב. בן 38, BMI-22 עם מדידות חוזרות של לחצי הדם 135/85.

ג. בן 42, BMI- 26, עם ערכי HDL- 32 מג%, ללא סיפור משפחתי של מחלות לב.

ד. בת 39, היקף מותניים 80 ס"מ וערכי LDL כולסטרול של 100 מג%.

75. בן 74, בריא בדרך כלל. מגיע אליך עם בקשה להוסיף לבדיקות הדם הבאות שלו גם בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן הערמונית.

מה ההמלצה לגבי בצוע הבדיקה ?

א. מעל גיל 70 אין המלצה לבדיקת סקר עם PSA.

ב. ערך PSA גבוה חד פעמי אינו אינדיקציה להמשך בירור.

ג. בדיקת DRE (Digital Rectal Examination) עדיפה על PSA כבדיקת סקר.

ד. אצל מעשנים מומלץ לעשות בדיקת סקר עם PSA.

76. בן 13 שנים, אושפז במחלקה פסיכיאטרית בכפיה לבקשת הוריו לאחר ניסיון אובדני שני.

מה יביא לשחרורו עקב הליך לא תקין?

א. הילד מסרב לאשפוזו.

ב. הילד אושפז בהוראת מתמחה בפסיכיאטריה של הילד.

ג. הילד התקבל בהוראת הנהלת בית החולים הפסיכיאטרי.

ד. הילד אושפז ללא המלצה של עובד סוציאלי לפי חוק הנוער.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

77. בת חמש שנים, שוקלת 22 ק"ג, פונה למרפאה ע"י אביה עקב פצע מזוהם בשוק. טופלה בחבישה עם משחה אנטיביוטית. לאחר מספר דקות חזרה בוכה ומפוחדת, משתעלת ובאי שקט פסיכומוטורי.
בבדיקתה - פנים סמוקות, קוצר נשימה, ל"ד 85/60 מ"מ כספי, דופק 150 לדקה, סטורציה 90% באוויר חדר.

קראת למד"א.

מה הטיפול הנדרש כעת עד שיגיעו?

א. Epinephrine 0.15 מ"ג S.C
ב. Epinephrine 0.15 מ"ג I.M
ג. Epinephrine 0.3 מ"ג S.C
ד. Epinephrine 0.3 מ"ג I.M

78. בהנחה שרופא המשפחה מכיר את הקטין ומשפחתו מה יכול רופא המשפחה לבצע?

א. לבדוק קטין בן 13 שהגיע לבד עקב כאבים בגרון, ללא אישור הוריו.
ב. לתת מרשם לטיפול אנטיביוטי לבן 16 שהגיע ללא ידיעת הוריו עם דלקת גרון.
ג. לדווח להוריה של ילדה בת 15 עם בדיקת הריון חיובית למרות התנגדותה.
ד. לסרב לרשום גלולות למניעת הריון לבת 17 שמסרבת לדווח על כך להוריה.

79. למי מהמטופלים הבאים יש להמליץ על שינוי בטיפול התרופתי?

א. בת 67, ברקע - אוסטאופורוזיס, מחלה פפטית, eGFR 40, מקבלת טיפול חד שנתי ב- Aclasta (Zolendronic Acid), תוסף סידן וויטמין D.
ב. בן 80, ברקע – עודף שומנים בדם, Barret Esophagus, MCI (Mild Cognitive Impairment), נוטל טיפול קבוע ב-PPI , Memorit (Donepezil).
ג. בן 70, ברקע - סכרת, IHD. נוטל טיפול תרופתי ב-Jardiance Duo (Metformin+Empagliflozin), Aspirin, סטטין, Tritace, Viagra (Sildenafil).
ד. בת 78, ברקע - מחלת פרקינסון, סכרת, נפילות חוזרות. נוטלת Sinemet (Carbidopa-Levadopa), Metformin, Aspirin, Risperdal (Risperidone).

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

80. בן 78 מתלונן על כאב בטן סביב הטבור. הכאב מופיע באופן קבוע כשעה לאחר אוכל ונמשך כשעה. ללא שינוי בהרגלי יציאה, הקאות או ירידה במשקל. ברקע מחלת לב איסכמית יציבה ומחלת כלי דם פריפרית.

בבדיקתו – BMI-34, בדיקת הבטן תקינה ללא ממצאים חריגים.

מהי בדיקת העזר שתקדם את האבחנה ?

א. גסטרוסקופיה.

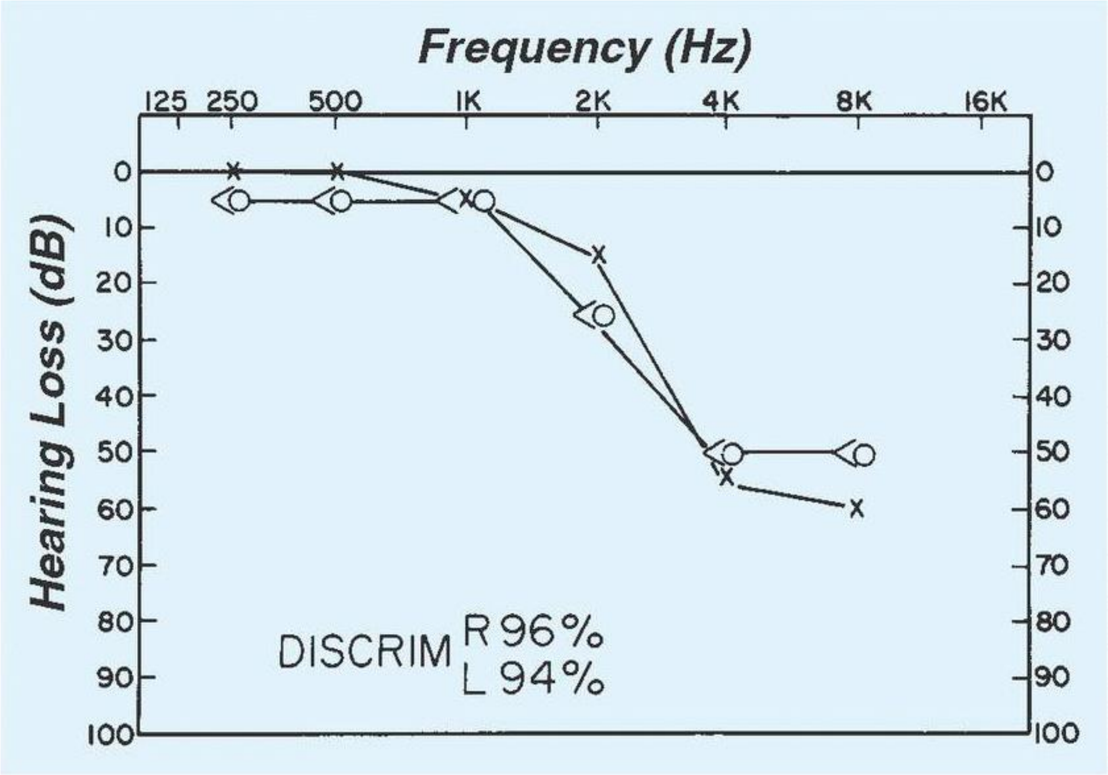
ב. CT-Angiography של הבטן.

ג. א.ק.ג. ובדיקת טרופונין.

ד. קולונוסקופיה.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

81. בת 60, מתלוננת על ירידה הדרגתית בשמיעה בחודשים האחרונים. סבלה ממספר אירועים קצרים של סחרחורת סיבובית. מצ"ב תוצאת בדיקת שמיעה:



מקרא: DISCRIM, discrimination; ×, left ear, air; O, right ear, air; <, right ear, bone; R, right; L, left.

מהי האבחנה הסבירה?

א. Acustic Neurinoma

ב. Meniere's disease

ג. Otosclerosis

ד. Presbiacusis

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

82. אם מביאה בן שניים וחצי לבדיקה בשל כאב אוזניים. ביקור אחרון במרפאה לפני חצי שנה.

באיזה מצב יש למדוד לחץ דם כחלק מהערכה הכוללת?

א. כל ילד המגיע למרפאה חייב בבדיקת לחץ דם.

ב. היסטוריה משפחתית של יתר לחץ דם אצל הסבים.

ג. לידה בשבוע 35 במשקל לידה תואם גיל הריון.

ד. היסטוריה של זיהומים חוזרים בדרכי שתן.

83. במחקר שיבדוק את הקשר בין חשיפה לטראומה לבין התפתחות דכאון.

מה צריכה להיות קבוצת ההשוואה (reference group)?

א. נבדקים ללא חשיפה לטראומה.

ב. נבדקים עם חשיפה טראומה.

ג. נבדקים ללא דכאון.

ד. נבדקים עם רקע של דכאון.

84. בן 58 ברקע יתר לחץ דם, מחלת לב איסכימית – מטופל באספירין, סטטינים וב- Tritace (Ramipril), בבדיקת מעבדה שגרתית:

TSH<0.1 (0.5-4.8)

FT3 =5.5(3.5-6.5)

FT4 = 17.5(11.5-22.7)

מה האבחנה והניהול המתאים?

א. מדובר ב- פעילות יתר של בלוטת התריס ויש צורך בהתחלת טיפול.

ב. מדובר בפעילות יתר תת-קליני, יש להתחיל טיפול תרופתי במינון נמוך.

ג. מדובר ב- Central Hypothyroidism , ש צורך בבירור על ידי CT.

ד. מדובר ביתר פעילות תת-קלינית ויש צורך במעקב תפקודי תריס כל חצי שנה.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

85. בן 67, הגיע עקב ירידה הדרגתית בעוצמה ותדירות של זקפה כולל זקפת בוקר, בחצי שנה אחרונה. חשק מיני שמור. המטופל בריא בדרך כלל, לא לוקח תרופות קבועות ואין לו תלונות נוספות. רמת סוכר בצום ורמות כולסטרול תקינות לפני 3 חודשים.

הוא מבקש לקבל Viagra.

איזו בדיקת מעבדה יש לבצע לפני מתן תרופה זו?

א. רמת טסטוסטרון בדם

ב. רמת PSA בדם

ג. אין צורך בבדיקות דם

ד. רמת המוגלובין המסוכר (HBA1C)

86. מטופל הסובל מצליעה לסירוגין המגבילה בתפקוד לאחר 50 מטר. נמדד ABI של 0.5.

מהו הטיפול המתאים ביותר למצבו?

א. בחומרה זו יידרש לטיפול התערבותי (ניתוח או צנתור).

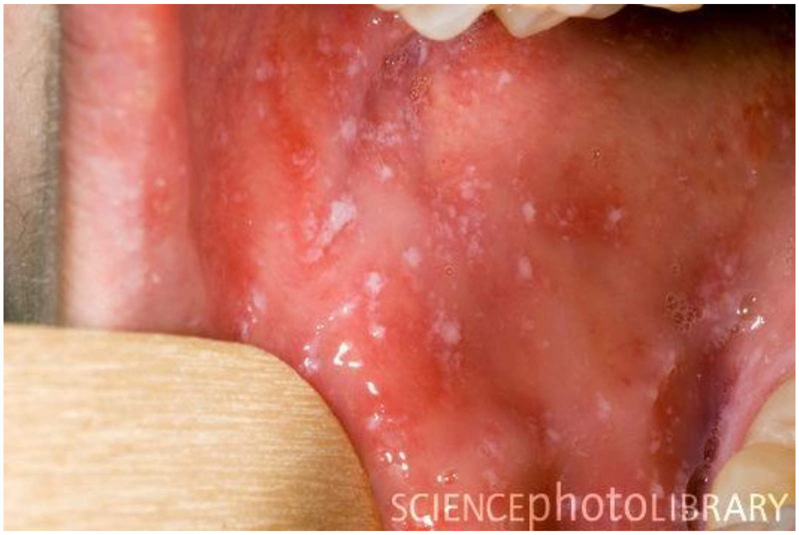
ב. להמליץ על הליכה עד הופעת כאב משמעותי, לנוח ולחדש את ההליכה .

ג. פיזיותרפיה לחיזוק שריר הארבע ראשי (Quadriceps)

ד. המלצה על עיסוי קבוע לשוקיים.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

87. בת 8, סובלת מחום גבוה מלווה בנזלת. בבדיקה גופנית נצפה הממצא הבא:



מהם מאפייני המחלה הנוספים?

א. תוך 1-2 ימים תופיע תפרחת שיורדת מצוואר ופנים לשאר הגוף.
ב. אנצפליטיס היא סיבוך שכיח – 1:130 מהמקרים.
ג. התפרחת צפויה להתפשט גם לכפות ידיים ורגליים.
ד. אין חיסון למחלה ולא ניתן למנוע העברה לסובבים.

88. בן 63, מטופל עקב פרפור פרוזדורים כרוני ב-Coumadin 5 mg, Atenolol (Normiten) 50 mg.
באקו לב האחרון – היצרות מיטראלית על רקע ראומטי והגדלה בינונית של חדר שמאלי. המטופל מרגיש טוב, ללא דפיקות לב או קוצר נשימה. בבדיקתו – לחץ דם 130/80, דופק 100 לדקה, לא סדיר, אוושה דיאסטולית גסה מוכרת.

INR 3 בשתי בדיקות עוקבות בהפרש של שבוע.

איזה שינוי טיפולי נדרש במטופל זה?

א. לא דרוש שינוי טיפולי
ב. החלפת Warfarin ב-Rivaroxaban (Xarelto)
ג. עלייה במינון של Atenolol (Normiten)
ד. החלפת Atenolol ב-Verapamil (Ikapress)

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

89. בת 50, בריאה ברקע, שבה מטיול של "מלכת המדבר" בדרום אמריקה לפני שבוע. בימים האחרונים סובלת מכאבים חזקים בכף הרגל באזור המטטרסלי שהולכים ומחמירים בייחוד בהליכה. ללא סיפור של חבלה או תנועה חדה. בבדיקתה – צליעה קלה, נפיחות באזור ה-forefoot, רגישות ניכרת במישוש בבסיס המטטרסליים של אצבעות 1,2.

מהו הצעד האבחנתי כעת?

א. CT כף רגל

ב. MRI כף רגל

ג. צילום כף רגל

ד. מיפוי עצמות

90. בת 17 מגיעה עם התפרחת המופיעה בתמונה מטה לאחר שחלתה בדלקת בשתן וטופלה בהתאם.

מהו ההסבר לגבי ממצאים אלה ?

א. התפרחת קשורה למחלה הזיהומית שבה חלה ו/או לטיפול האנטיביוטי שנטל.

ב. אין צורך במעקב כי המצב ישתפר בכל מקרה.

ג. התפרחת בדרך כלל נגרמת כתוצאה מחיידק בעור.

ד. לא דווחו סיבוכים כתוצאה ממצב זה.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

91. בת 35, נ+0 ,בריאה בד"כ, סובלת מדימום וסתי מוגבר בשנה האחרונה, בעל שמע (US) גניקולוגי ממצא של שרירן רחמי.

מהו הטיפול המומלץ?

א. גלולות משולבות יעילות יותר בהפחתת דימום וסתי מאשר שימוש ב- Levonorgestrel-releasing intrauterine system (Mirena).

ב. טיפול ב NSAIDS יכול לסייע בהפחתת דימום וסתי מוגבר.

ג. מיומקטומיה בנשים עם שרירן Intramural תקטין דימום וסתי מוגבר.

ד. מיומקטומיה הינה הפרוצדורה הניתוחית המועדפת בנשים עם שרירן Intramural אשר מעוניינות לשמר פוריות.

92. בן 30 פנה עקב אירועים חוזרים של כאב ראש עז, חד צדדי, הנמשך בכל אירוע כשעה, לפעמים מספר ימי ברצף, לאחר מכן הפוגה של כחודש והישנות. בעת אירוע פטוזיס, גודש אף ונפיחות של העפעפיים בצד הכאוב. הכאב עז ביותר ומגביל בעבודתו.

מהו הטיפול היעיל ביותר למניעת הישנות אירועים?

א. טיפול בחמצן בשעת השינה או טיפול היפרבארי.

ב. שימוש קבוע ב-Amlodipine.

ג. שימוש קבוע ב-Tegretol (Carbamazepine).

ד. שימוש קבוע ב-Licarbium (Lithium).

93. בן 14, בריא בדר"כ, מגיע עם הוריו. מספרים כי מזה מספר חודשים מצב רוחו ירוד ועצבני, לא רוצה ללכת לחוג כדורגל שהוא לרוב אוהב, לא מצליח להתרכז בלימודים. נמצא במעקב וטיפול ונשקל טיפול תרופתי.

מה הטיפול התרופתי המתאים ביותר?

א. Prizma (Fludoxetine)

ב. Clonex (Clonazepam)

ג. Ritalin (Methylphenidate)

ד. Elatrol (Amitrityline)

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

94. בת 67 ידוע על סכרת מגיל 60. BMI 35.

מקבלת טיפול תרופתי על ידי Glucophage (Metformin) – 2 פעמים ביום, יחד עם זריקות Trulicity (Dulaglutide) 1.5 מ"ג פעם בשבוע.

בבדיקות המעבדה – סוכר בצום 155 מג%, המוגלובין A1C - 7.7%, התפקוד הכלייתי eGFR= 50 מ"ל/דקה.

מהו הטיפול התרופתי המומלץ ביותר עבורה?

א. המשך אותו טיפול תרופתי.

ב. הפסקת ב-Metformin ומעבר ל-Insulin.

ג. הוספת Forxiga (Dapagliflozin).

ד. הוספת Januvia (Sitagliptin).

95. בן 65 עבר לאחרונה התקף של אבני כליה. מתלונן על כאבים בירך.

בבדיקות הדם: Alkaline Phosphatase 140 u/L (normal 30-120) ,

Uric Acid 7 mg% (normal 3.5 – 7.2), Calcium 11 mg% (normal 8.5-10.5).

בצילום ירך: התגלו אזורים ליטיים ואזורים עם עליה בצפיפות העצם והרחבה של העצם הטרבקולארית.

מיפוי עצם: מראה אזורים בעלי קליטה רבה.

מהי האבחנה הסבירה ביותר?

א. Multiple Myeloma

ב. Paget's Disease

ג. Osteomalacia

ד. Prostate Cancer

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

96. בן 12.5, בריא בד"כ ומחוסן כפי גילו. בשבועיים האחרונים מתלונן על כאבים באזור המפשעה מצד ימין וכאב עמום בירך ימין, מתקשה לעשות ריצות, שולל חבלה.

בבדיקתו - חום 36.5 מ.צלזיוס, רגל ימין בסיבוב חיצוני, כאב בכיפוף הירך מעל 90 מעלות, הגבלה משמעותית בסיבוב פנימי.

בצילום:

מה האבחנה הסבירה?

א. מחלת פרתס (Perthes disease).
ב. שבר בצוואר הירך מצד ימין.
ג. Slipped capital femoral epiphysis.
ד. Juvenile idiopathic arthritis.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

97. בן 70 מתלונן על כאבי גב מרכזיים (טורקליים) וחולשה.

בבדיקות המעבדה:

המוגלובין – 11.5 גרם%, ערכי קריאטינין 1.5 מג%, וערכי סידן 11 מג% (ערך תקין עד 10.5 מג%) ערכי Total Protein - 8.4 גרם % (ערכי נורמה 6.6-8.3 גרם%), ובשתן נצפתה הפרשת חלבון +++.

איזו בדיקה תקדם את האבחנה החשודה?

א. מיפוי עצמות SPECT.

ב. הערכה של חלבוני הדם ואימונוגלובולינים.

ג. בדיקת צפיפות העצם.

ד. שקיעת דם ו- CRP.

98. בת 80, הסובלת מסרטן לבלב גרורתי. חלה החמרה במצבה. כעת אינה יכולה לדבר, לאכול או לשתות ונשקלת הזנה מלאכותית. בגיל 70 היא חתמה על מסמך הנחיות רפואיות מקדימות בו כתבה שאינה מעוניינת בהזנה מלאכותית בשום מצב. בנה מבקש מהצוות הרפואי לכבד את ההנחיות.

כיצד יש לנהוג במצב זה מבחינה חוקית?

א. מכיוון שעברו 10 שנים מחתימת המסמך, פג תוקפו ואין להתחשב בו.

ב. ההנחיות בתוקף מרגע שחתמו עליהן וחובה לכבדן.

ג. ניתן להתחשב בהנחיות למרות שפג תוקפן.

ד. יש צורך באישור וועדת האתיקה כדי להתחשב בהנחיות.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

99. בן 50 מתלונן על כאבים בזמן יציאה מזה 5 ימים. בבדיקת PR נמצא הממצא הבא:

מהו הטיפול המתאים היותר?

א. מתן סיבים תזונתיים.

ב. מריחת משחת ניפדיפין 3%.

ג. ניקוז ניתוחי.

ד. ביופידבק.

100. בן 78, סבל מנימול וחולשה של יד ימין שחלפו תוך 30 דקות. אינו סובל ממיגרנות או אפילפסיה, רמת סוכר נמדדה תקינה בסמוך לאירוע, לחץ הדם היה 130/70 באירוע ולאחריו. בבירור רמת הומוציסטאין מוגברת. באקו לב ממצא של PFO (Patent Foramen Ovale) קטן.

מה ההמלצה הטיפולית המתאימה ביותר?

א. הליכה יומית סדירה.

ב. לחצי דם תקינים, אין צורך בטיפול בתכשירי ACEI

ג. לשקול סגירת ה-PFO בהקדם.

ד. להפחית רמת הומוציסטאין עם תוספי חומצה פולית.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

101. בת 26, ברקע – השמנה: BMI 41, נוטלת גלולות מגיל צעיר בשל מחזור לא סדיר, מתייעצת לגבי הריון עתידי.

מהי ההמלצה המתאימה ?

א. יש לחסנה לשעלת (Pertusis) כהכנה לקראת ההיריון.

ב. יש לדחות ניתוח בריאטרי לאחר השלמת תוכניות הילודה שלה.

ג. בדיקה לרמת החומצה הפולית.

ד. ההשמנה מעלה את הסיכון למום פתוח בתעלה העצבית בעובר.

102. במחקר שבדק את רמת כולסטרול בדמם של 1000 מתגייסים לצבא, נמצא כי רמת הכולסטרול הממוצעת הייתה 180 מ"ג% וסטיית התקן הייתה 20 מ"ג%.

באיזה אחוז מאוכלוסיית המחקר נמצאה רמת כולסטרול בין 160-200 מ"ג/לדציליטר?

א. 33.3%

ב. 50%

ג. 66.6%

ד. 95%

103. בת 80, צלולה בדרך כלל, לאחר CVA. מתגוררת בביתה עם מטפלת. מזה שבוע ירידה כללית במצבה, חלשה, משתעלת. המטפלת מדדה חום PO 37.4, מדווחת על אירוע של השתנקות בזמן האוכל לפני כשבוע וחצי. בבדיקתה נראית מעט חיוורת, 22 נשימות לדקה. ל"ד 125/78, דופק 90. בהאזנה לריאות קרפיטיות בבסיס ריאה ימנית.

מה הטיפול המתאים ביותר למטופלת זו במסגרת אמבולטרית?

א. Azythromycin (Azenil)

ב. High dose Amoxicillin (Moxypen)

ג. Clindamycin (Dalacin)

ד. Cefuroxime (Zinnat)

104. עבור איזה מהמטופלים הבאים יעד המטרה של LDL הינו מתחת ל 55?

א. בן 50 עם סכרת מזה 5 שנים ויתר לחץ דם.

ב. בת 57 ברקע יתר לחץ דם ואי-ספיקת כליות דרגה 3.

ג. בן 42 הסובל מהיפרלפדמיה משפחתית ללא גורמי סיכון נוספים.

ד. בן 65 ברקע מחלת לב איסכמית מזה 5 שנים ללא גורמי סיכון נוספים.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

105. משפחת ישראלי מורכבת מהורה 1, הורה 2 ו ארבעה ילדים בני 14,10,8,5 שנים. סבתם גרה בסמיכות ומסייעת לסירוגין בטיפול בילדים. עקב משבר הקורונה ירידה בתפקוד המשפחתי ובלכידות.
בהתחשב בשלב במעגל החיים בה נמצאת משפחת ישראלי, מה המשימה ההתפתחותית הרלוונטית במשפחה זו?

א. העלאת הגמישות של הגבולות תוך מתן אפשרות של עצמאות למתבגרים.
ב. התמקדות בזוגיות ובקידום הקריירה.
ג. ארגון מחדש של המשפחה במשימות תחזוקת הבית.
ד. התמודדות עם הורים מזדקנים והטיפול בהם.

106. בן שנה וחצי בריא בד"כ. פיתח תפרחת מפושטת מגרדת לאחר מתן מוקסיפן.
כעת סובל מדלקת אוזן תיכונה חדה דו צדדית, חום 39.6 מעלות צלזיוס.
מהו הטיפול המומלץ?

א. Resprim (Trimethoprim-sulfamethoxazole)
ב. אין צורך בטיפול אנטיביוטי בשלב זה
ג. Erythromycin
ד. Zinnat (Cefuroxime)

107. בת 40, בריאה בד"כ, BMI 30. מתלוננת על כאב ביד ימין ונימול באצבעות 1 2 3 יד ימין, קמה בלילה ומנערת את היד על מנת להעביר תחושת הנימול ומדווחת שדברים נופלים לה מהיד.
מה מקדם את האבחנה וההחלטה הטיפולית ?

א. בדיקת US נחוצה לפני החלטה על טיפול ניתוחי.
ב. בדיקות EMG +NCT עוזרות בקביעת חומרת המחלה ולהחלטה הטיפולית.
ג. בדיקת MRI נחוצה בחולים עם מחלה בדרגת חומרה קשה קלינית לאימות האבחנה.
ד. אנמנזה ובדיקה גופנית עוזרות להגיע לאבחנה אך לא בקביעת חומרת המחלה.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

108. בתה של מטופלת בת 80 מתייעצת אתך לגבי הפעלת חוק סיעוד עבור אמה הקשישה.
מהו ההסבר לגבי חוק סיעוד ?

א. החוק מאפשר לקשישים מגיל 70 לקבל רק שירותי סיעוד (כמו מטפלת) ללא אפשרות לקבלת תגמול כספי.
ב. הזכאות לקבלת סיוע ניתנת לכל אדם המתגורר בביתו, או במוסד סיעודי.
ג. יכולת תפקוד נקבעת לפי יכולת טיפול עצמי - הליכה לבנק, לקניות, ביצוע כביסה וניקיון הבית.
ד. מגיל 90 מספיקה המלצת רופא גריאטר על מנת לקבל את הגמלה.

109. בת 82, צלולה ועצמאית. ברקע – יתר לחץ דם וסכרת מאוזנים. פונה בשאלה של ביצוע ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד.
מהי ההמלצה לגבי בצוע ממוגרפיה ?

א. אין מקום לבצע בדיקת ממוגרפיה לגילוי מוקדם מעל גיל 75.
ב. ניתן לשקול ביצע ממוגרפיה בהתאם למצבה הרפואי והתפקודי ותוחלת החיים הצפויה.
ג. מאחר ואין לה היסטוריה משפחתית של סרטן שד היא אינה מתאימה לביצוע ממוגרפיה.
ד. בשל גילה היא נמצאת בקבוצת סיכון ויש לזמנה לבצע בדיקת סקירה.

110. בן 65 פונה עקב תחושה של דפיקות לב. ברקע יתר לחץ דם, מטופל ב-Exforge160/10 mg (Valsartan + Amlodipine). בד"כ לחצי הדם מאוזנים סביב 130/80.
בבדיקתו - ל"ד 150/110 דופק 70, בדיקה גופנית ונירולוגית תקינה, אקג תקין,
מה הטיפול כעת?

א. מתן S.L. Captopril 12.5 mg.
ב. הוספת Amlodipine 5 mg.
ג. ללא שינוי בטיפול , יש לזמנו לביקורת למחרת.
ד. החלפת טיפול ל-Tritace comp 5/12.5 mg.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

111. התחלת טיפול ב-Methylphenidate (Ritalin) לילדה בת 10, בריאה בד"כ, ללא מחלות במשפחה.
איזה מעקב נדרש לבצע באופן תקופתי?
א. אק"ג.
ב. דופק ולחץ דם.
ג. ספירת דם ותפקודי כבד.
ד. אין צורך במעקב.

112. מחקר בדק השפעה של תרגול יוגה על לחץ דם.
במשך שנה נבדקו שתי קבוצות מטופלים עם יתר לחץ דם, מאפייני רקע דומים.
בסוף המחקר דיווחו החוקרים כי בקבוצה שתרגלה יוגה נמדדו בממוצע ערכי לחץ דם נמוכים מאשר בקבוצה שלא תרגלה יוגה, עם RR=0.9, רווח סמך של 95% (0.5-2.0) ו- p-value של 0.04.
כיצד ניתן לפרש את תוצאות המחקר?
א. תרגול יוגה עשוי להפחית יל"ד אצל מטופלים עם יל"ד.
ב. תרגול יוגה אינו משפיע על יל"ד אצל מטופלים עם יל"ד.
ג. תרגול יוגה עשוי להגביר יל"ד אצל מטופלים עם יל"ד.
ד. יש טעות בחישובים – לא יתכן צירוף תוצאות כזה.

113. בן 26, מגיע עם בת זוגו. היא מספרת כי לפני כשבועיים היה במצב רוח מרומם, פעיל מאוד, דיבר הרבה, ישן מעט, היה יצירתי וחד בצורה מרשימה. הפתיע אותה עם רכב חדש ויוקרתי. כעת כ-5 ימים חלש ומדוכדך, בוכה, לא מתפקד, מתקשה להסביר את השינוי ולא מצליח לחזור למצבו הקודם. שולל מחשבות אובדניות. המטופל בריא בד"כ, שולל שימוש בסמים או אלכוהול.
מהו הטיפול המתאים ביותר עבורו?
א. טיפול בנוגד דיכאון Cipralex (Escitalopram) 10 mg.
ב. הפנייה מידית לטיפול ע"י פסיכיאטר.
ג. טיפול ב- CBT או פסיכותרפיה.
ד. הוצאת צו לבדיקה כפויה.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

114. בת 27, מעוניינת להרות. פונה להתייעץ בשל מחזור לא סדיר – מתרחש פעם בחודשיים.
בבדיקתה: BMI 24, אקנה ניכר ושיעור יתר בפנים.
מהו הטיפול המתאים למטופלת זו עם הסיכוי הטוב ביותר להריון שיסתיים בלידת ילוד חי?
א. Ikaclomin (Clomiphene)
ב. ירידה במשקל של 5%
ג. Femara (Letrozole)
ד. Glucophage (Metfotmin)

115. לפניך תוצאות בדיקות דם של מטופל בן 64: GFR13, זרחן (P) 6 מ"ג/ד"ל.
מהי ההמלצה הטיפולית עבורו ?
א. טיפול ב Sodium polystyrene sulfonate (Kayeoxalate)
ב. Aluminum-based phosphate binders
ג. משתנים מקבוצת Thiazide
ד. טיפול ב-Calcium Carbonate

116. מבין הנשים המתוארות להלן, מי נמצאת בסיכון לפתח מחלת תירואיד בהריון?
א. אישה המאובחנת עם סכרת הריון, מאוזנת תזונתית.
ב. אישה המאובחנת עם טרשת נפוצה ללא התקפים בשנה האחרונה.
ג. אישה הסובלת מאפילפסיה מאוזנת תרופתית.
ד. אישה שאחותה אובחנה לאחרונה עם סקלרודרמה.

117. בן 15, מאובחן כסובל מאסטמה. תדירות התקפים של קוצר נשימה היא פעם בחודש ללא התקפים ליליים.
מהו הטיפול המומלץ לפי הנחיות GINA?
א. משאף Ventolin (Salbutamol) לפי הצורך.
ב. אינהלציה של Ventolin (Salbutamol) עם Aerovent(Ipratropium Bromide).
ג. משאף Budicort (Budesonide) לפי הצורך.
ד. משאף Foster (Formeterol + Beclomethazone) לפי הצורך.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

118. בן 44, מכור לאלכוהול.

באיזה מקרה סיכויי ההצלחה הגבוהים ביותר לתהליך גמילה על ידי רופא המשפחה?

א. במקרה של הפרעה משמעותית בתפקודי הכבד.

ב. כשהמטופל משתמש באופן קבוע בקנביס.

ג. ניסיון קודם של גמילה במסגרת מוסדית נכשל.

ד. ההתמכרות לאלכוהול נמשכת כ- 10 שנים.

119. בן 4, אימו פנתה עקב גרד משמעותי בראש מזה מספר ימים. לאחרונה התחיל גן ילדים חדש. לדברי האם ילדה נוספת בגן מתגרדת.

אילו ממצאים יכולים להימצא בבדיקה גופנית?

א. ביצים, אזורי אובדן שיער, הגדלת בלוטות צוואריות, תפרחת אדומה בכפות ידיים.

ב. קרציות, פצעים מפרישים על הראש, אקזמה על הצוואר ומסביב העיניים.

ג. ביצים, פצעים מפרישים על הראש, הגדלת בלוטות צוואריות, אקזמה על הצוואר ומאחורי האוזניים.

ד. כינים, תפרחת פפולרית, אזורי אובדן שיער, אקזמה על הצוואר, פריחה בכפות ידיים.

120. צעירה סובלת מכאבים בבטן העליונה מזה ארבעה חודשים. עברה בירור נרחב כולל גסטרוסקופיה שהייתה תקינה.

איזו תלונה תומכת ב-ulcer-like functional dyspepsia על פי Rome criteria?

א. הכאב מוחמר לאחר אוכל

ב. הכאב לא מוקל על ידי נוגדי חומצה

ג. הכאב מעיר את המטופלת מהשינה

ד. הכאב קבוע ואין תקופות של הפוגה (רמיסיה)

121. בן 30, שחקן כדור סל. מתלונן על כאב קדמי בברך ימין שהחמיר בהדרגה ללא חבלה. מחמיר בפלקסיה ופעילות ממושכת ובתרגילי Squats לא מצליח לכופף את הברכיים מספיק ומתקשה לעשות את התרגיל. בבדיקה רגישות במישוש הקוטב התחתון של הפטלה.

מה האבחנה הסבירה ביותר?

א. MED. MENISCUS TEAR

ב. ANT. CRUCCIATE LIGAMENT TEAR

ג. STRESS FRUCTURE

ד. PATELLAR TENDINOPATHY - JUMPERS KNEE

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

122. במחקר קוהורט שנעשה על מבוטחי מחוז מסוים של קופת חולים לאורך חציון ראשון של 2020, נמצא כי שיעור המבוטחים עם הפרעה אובססיבית קומפולסיבית (OCD) שאומתו לקורונה היה 4% ואילו שיעור המבוטחים ללא הפרעה זו שאומתו לקורונה היה 8%.

מהי המסקנה באשר לתוצאות המחקר שהוצג?

א. ירידת הסיכון היחסית (Relative Risk Reduction) בקרב מטופלים עם OCD היא של 4%.

ב. ירידת הסיכון האבסולוטית (Absolute Risk Reduction) לקורונה במטופלים עם OCD היא של 50%.

ג. המחקר מוכיח ללא ספק קשר סיבתי בין OCD כגורם מגן לבין הדבקה בקורונה.

ד. הסיכון היחסי (Relative Risk) של מטופלים עם OCD במחקר זה ללקות בקורונה הוא 0.5.

123. בן 54, נבדק ע"י רופא עיניים אשר מדד לחץ תוך עיני של 25 מ"מ כספית, cup to disk ratio גבוה, בבדיקת שדה ראייה תוארה ירידה בשדה ראייה פריפרי. הוחל טיפול לפני כשבועיים. בהגעתו למרפאה מתאר מאז התחלת הטיפול עייפות, יובש בפה. בבדיקתו לחץ דם 100/60.

מהו הגורם הסביר ביותר לתלונותיו?

א. Pilocarpine

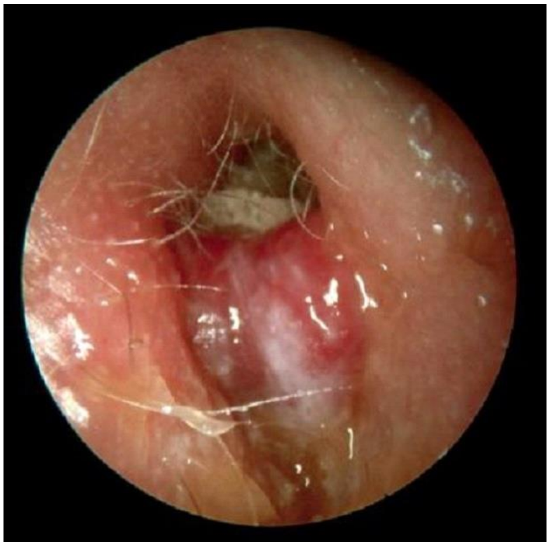
ב. Alphagan (Brimonidine)

ג. Travatan (Travoprost)

ד. Tiloptic (Timolol)

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

124. בת 50, ברקע - אסטמה, השמנה, טרום סכרת, פסוריאזיס. מטופלת במשאף Flutiform.
מזה כשבוע כאבים חזקים באוזן שמאל, מתקשה לישון בלילה. בבדיקה הממצאים הבאים:



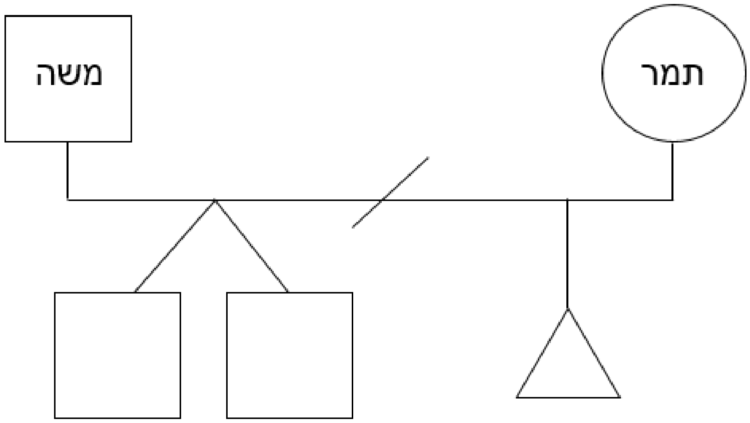
מהו הטיפול לאבחנה הסבירה ביותר?

א. טיפול אנטיביוטי מקומי לדלקת אוזן תיכונה.
ב. טיפול במי חמצן וחומצה בורית לדלקת אוזן חיצונית.
ג. טיפול ב-Fluoroquinolones לדלקת אוזן חיצונית.
ד. טיפול ב-Resprim (trimethoprim/sulfamethoxazole) לדלקת אוזן תיכונה.

125. בן 8, האם מתארת שמזה כחצי שנה סובל משיעול, ללא חום, ללא קוצר נשימה ללא תסמינים נוספים. השיעול מופיע רק בשעות היום, לא בעת שינה, ואינו מגיב לטיפול במרחיבי סמפונות. בוצע צילום חזה – תקין.
מהי הגישה המומלצת?
א. טיפול במשאף סטרואידלי.
ב. טיפול אנטיביוטי.
ג. טיפול בתכשירי PPI .
ד. הרגעת ההורים שאין מדובר בבעיה אורגנית.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

126. לפניך תרשים של אילן משפחתי:



תאר/י במילים את התרשים.

א. למשה ותמר, זוג פרוד, נולדו תאומים זהים. תמר בהריון כעת.
ב. למשה ותמר, זוג גרוש, נולדו תאומים לא זהים. תמר עברה הפלה (abortion) בהריונה האחרון.
ג. למשה ותמר, זוג גרוש, נולדו תאומים לא זהים. תמר בהריון כעת.
ד. למשה ותמר, זוג פרוד, נולדו תאומים לא זהים. תמר בהריון כעת.

127. בן 65 מתלונן על חולשה ועייפות.

בבדיקות המעבדה – המוגלובין 10.8 גרם%, ערכי MCV – 101, ערכי RDW – 17 (גבוה),

ספירת Reticulocytes - 7% (גבוה).

חומצה פולית – 17 מג% ורמת ויטמין B12 – 280 מיקרוגרם%.

איזו בדיקה תבסס את האבחנה הסבירה ביותר?

א. TSH.
ב. Creatinine.
ג. Haptoglobin.
ד. ביופסיה של מח עצם.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

128. בת 40 מתלוננת על עייפות, תשישות, וכאבים באזורים שונים בגופה מעל חצי שנה.
בדיקה - רגישות ללחיצה ב-14 נקודות שונות בגופה. ללא עדות לסינוביטיס או ארטריטיס.
בדיקות דם ללא ממצא מכוון.
לאור החשד הקליני הסביר ביותר איזה טיפול הוא היעיל ביותר?

א. הקלת הכאב בתכשירים Opioids.
ב. תרופות נוגדות דלקת מקבוצת NSAID.
ג. טיפול בתכשיר נוגד דכאון מקבוצת הטריציקליים.
ד. טיפול הרגעתי בתכשיר Benzodiazepine.

129. פעוט בן 3 מובל בבהלה מהגן הסמוך למרפאה. הגננת מספרת שהילדים היו במהלך פעילות יצירה כאשר הפעוט קם מהכיסא מבוהל, מתקשה לנשום. האירוע התרחש לפני 2 דקות, במרפאה הילד בהכרה, ללא חום, נראה במצוקה, צבע עורו תקין, נושם בכבדות עם פה פתוח, נשמע רעש אינספירטורי.
מה הצעד הבא בטיפול בילד?

א. מתן דחוף של רוצפין והזמנת נט"ן לפינוי דחוף.
ב. בחשד ל-Croup להתחיל מיד באינהלציה עם אדרנלין וחמצן ובמקביל להזמין אמבולנס.
ג. לבקש מהילד להשתעל, במידה והוא לא מצליח ,לבצע 5 לחיצות בטן.
ד. להשכיב את הילד על הגב, לנסות לזהות ולשלוף גוף זר, להתחיל בהנשמה.

130. מטופלת שלך עברה תאונת דרכים לפני 4 שנים. היא פונה אליך בטלפון ומבקשת כי תדפיס/י מתוך הרשומה שלה את הביקורים שלה בנושא זה אצלך, אצל רופא אורתופד ורופא נוירולוג, לצורך הגשת תביעה משפטית.
כיצד עליך לנהוג לגבי הפקת מידע רפואי במקרה זה?

א. על המטופלת לפנות למשרד הרשומות בקופת החולים, לשלם ולחתום על טופס "ויתור סודיות" לצורך קבלת המסמכים.
ב. המטופלת רשאית לקבל לידיה מידע מהרשומה הרפואית שנכתבה על ידי הרופא אליו פנתה לאחר הזדהות בפניו, ותוך ציון הדבר בתיק.
ג. מכיוון שהבקשה היא לצורך תביעה משפטית רק חברת הביטוח יכולה לפנות ללשכה המשפטית לקבלת החומר.
ד. לפי חוק זכויות החולה המידע שייך למטופלת ולכן אדפיס לה את התיק הרפואי כולו.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

131. בת 45, בריאה בד"כ, מתלוננת על נפיחות באזור הגניטלי, המלווה באי נוחות בזמן הליכה וישיבה וכאב בקיום יחסי מין.

בבדיקה: מצב כללי טוב, ללא חום סיסטמי, ממצאים שבתמונה המצורפת. ללא אודם משמעותי או חום מקומי.

מה הטיפול במצב זה?

א. ביצוע ניקוז של הממצא ע"י מחט/חתך.

ב. טיפול אנטיביוטי ב-Augmentin 875 מ"ג פעמיים ביום לשבוע.

ג. הממצא יחלוף עצמונית, אין צורך בטיפול.

ד. לאור גיל המטופלת יש לבצע ביופסיה מהנגע לפני תחילת טיפול.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

132. בת 35, סובלת מהתקפי מיגרנה פעמיים בשבוע.

מהו הקו הראשון של טיפול מונע עבורה?

א. Imitrex (Sumatgriptan).

ב. Topamax (Topiramate).

ג. Amlow (Amlodipine).

ד. Cipralex (Escitalopram).

133. בן 40, מטופל ב-Valsartan. פונה אליך עקב שיעול יבש מזה חודש וחצי שהחל לאחר URTI. השיעול אינו מוחמר בלילות. מציין כי חזר זה עתה מטיול במזרח של חצי שנה וכי חוסן במסגרת מרפאת מטיילים טרם הנסיעה לפי ההמלצות.

בבדיקתו: נינוח נשימתית, סטורציה באוויר חדר 97%. בהאזנה לריאות נשימה בועית תקינה, ללא צפצופים או קראפיטציות.

מהי האבחנה הסבירה ביותר?

א. Postinfectious cough.

ב. שיעול משני לטיפול התרופתי.

ג. Upper airway cough syndrome (Post-nasal drip).

ד. שעלת (Pertussis).

134. בת 50, מזה 8 שבועות סובלת מכאבים בפרקי כפות הידיים, מלווים בנוקשות בוקר שנמשכת מעל 30 דקות.

בבדיקה גופנית קיימת נפיחות בפרקי Metacarpophalangeal (MCP) בשתי הידיים.

במעבדה – Rheumatoid Factor שלילי, בדיקת Anti-CCP (Anti Cyclic Citrullinated Peptide) מראה ערך חיובי חלש, ESR 50 לשעה, CRP=0.6(normal <0.5).

מהו הטיפול ההתחלתי המומלץ?

א. תכשיר מקבוצת NSAID בשילוב עם Prednisone 20 mg ליום.

ב. טיפול ביולוגי במעכבי IL6 - Actemra (Tocilizumab).

ג. טיפול בסטרואידים במינון גבוה Prednisone 60 mg ליום.

ד. סטרואידים במינון Prednisone 10 mg בשילוב עם Methotrexate.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

135. תינוק בן 8 חודשים , מגיע למרפאה בלווית אמו עקב הממצא המוצג בתמונה הבאה.

בבדיקתך corneal light reflex סימטרי במרכז 2 העיניים, במבחן cover- uncover ללא תנועה מתקנת.

מהי ההמלצה במקרה זה ?

א. הבעיה תחלוף עם הגיל.

ב. יש צורך בטיפול במשקפיים.

ג. הטיפול המומלץ הינו ניתוחי.

ד. יש לכסות את העין הבריאה.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

136. בת 70, ברקע - השמנת יתר, סכרת ויתר לחץ הדם. מטופלת ב- Enaladex (Enalapril) 10 mg, Vasodip (Lercanidipine) 10 mg, Cardiloc (Bisoprolol) 5 mg. בתקופה האחרונה מתלוננת על קוצר נשימה במאמץ קל ובצקות ברגליים, הוסף לטיפול ב- Fusid 80 mg שלא הביא לשיפור במצבה.
בבדיקה - לחץ דם 130/80, דופק 60, המוגלובין 12 גרם%, TSH תקין, eGFR 25 ml/min,
אלקטרוליטים תקינים. צילום חזה תקין, אקו לב מראה הפרעה ברלקסציה ו- EF=50%.
מהו הטיפול בשלב זה?

א. להעלות מינון Enaladex ל- 20 מג ליום.
ב. להחליף Vasodip ב- Amlodipine.
ג. להחליף Enaladex ב- Entresto (Sacubitril).
ד. להוסיף טיפול ב- Aldospirone.

137. מטופלת מתלוננת על כאבים בכף הרגל - באזור שמסמנת בקצות אצבעותיה.
הכאב חזק יותר בבוקר כשקמה מהמיטה ונחלש במשך היום.

מהי הסיבה לכאב?

א. Calcaneal stress fracture
ב. Tarsal tunnel syndrome
ג. Achilles tendinitis
ד. Plantar fasciitis

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

138. בן 74 הסובל מפרפור פרוזדורים על רקע היצרות מסתם מיטרלי בדרגה קשה.
מקבל טיפול קבוע ב-(Coumadin (Warfarin. עבר בדיקת INR שגרתית - התוצאה היא 6. באנמנזה אין חשד לדימום.
מהי ההמלצה הטיפולית?
א. להפסיק טיפול למשך יומיים.
ב. לתת ויטמין K.
ג. לתת Fresh Frozen Plasma.
ד. לעבור לטיפול ב(Eliquis (apixaban.

139. מה הטיפול המתאים ביותר לגרד בחולה במצב טרום דיאליזה?
א. מתן אנטיהיסטמינים במינון מותאם כלייתי.
ב. טיפול ב-(Seroxat (Paroxetine.
ג. טיפול ב-(Lorivan (Lorazepam.
ד. טיפול ב-Cholestyramine.

140. מטופלת הסובלת מדלקת מעי כיבית (ulcerative colitis) עם מספר התלקחויות בעברה כעת בהריון. היא מטופלת בתכשיר Pentasa (5-Aminosalycilic Acid) באופן קבוע ונמצאת בהפוגה.
יש לציין שהתכשיר מאושר לשימוש במהלך הריון , המטופלת מתייעצת עמך לגבי הצורך בטיפול במהלך ההיריון.
מהי ההמלצה הטיפולית המתאימה ביותר בשלב זה ?
א. להמשיך בטיפול הקבוע ללא שינוי
ב. להפסיק את הטיפול עד השלמת organogenesis של העובר.
ג. לעבור לטיפול ביולוגי במהלך ההיריון.
ד. להפסיק טיפול ולחדשו בטרימסטר שלישי לקראת הלידה.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

141. בת 41, BMI-40, כשנה לאחר לידתה השישית. מלינה על אירועים חוזרים של כאב בבטן ימנית עליונה. הכאבים מופיעים לאחר ארוחה, לעתים עזים ביותר, עד כה חלפו מעצמם לאחר שעות אחדות. ללא צהבת, ללא שינוי ביציאות. בבדיקתה בטן רכה, לא רגישה, ללא סימני גירוי ציפקי.

איזו בדיקה ראשונית תבצע על מנת להגיע לאבחנה?

א. גסטרוסקופיה

ב. US בטן

ג. צילום בטן סקירה

ד. CT בטן

142. בת 20, בביקורת גניקולוגית נצפה משטח PAP תקין. נמצא HPV חיובי זן 16.

מהו המשך הבירור המומלץ?

א. בדיקת PAP חוזרת בעוד 3 שנים

ב. בדיקת PAP חוזרת בעוד שנה

ג. בדיקת PAP חוזרת בעוד חצי שנה

ד. קולפוסקופיה

143. בן 54, ברקע השמנת יתר, יתר לחץ דם, בעברו עישון 30 שנות חפיסה, הפסיק לפני שנה. מתלונן על שיעול פרודקוטיבי מזה מספר חודשים, מלווה בקוצר נשימה במאמצים.

מה הכרחי לקביעת אבחנה של COPD?

א. הדמיה – צילום או CT בית חזה.

ב. ספירומטריה.

ג. הערכתן DLCO, ו- residual volume.

ד. האבחנה קלינית לאור גורם סיכון ותסמינים אופייניים.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

144. בן 4, בריא, ללא בעיות אוזניים עד כה. מגיע בליווי הוריו עקב תחושת אי נעימות ומלאות באזניים מזה כשבועיים. ללא חום, ללא כאבי אזניים וללא תסמיני URTI.

בבדיקה באוטוסקופ נצפה בשתי האוזניים הממצא הבא:

מהי הגישה המומלצת במקרה זה?

א. מעקב עוד 3 חודשים.

ב. טיפול במפיגי גודש, אנטיהיסטמינים ותרסיס סטרואידים נזאלי.

ג. טיפול ב-(Moxypen (Amoxicillin.

ד. השגחה למשך 48-72 שעות ואם ישנה החמרה יש לטפל ב-(Moxypen (Amoxicillin.

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

145. בן 45, לא מעשן ,בעברו תסחיף ריאתי, מטופל ב-(Apixaban) Eliquis X2 5 mg ביום, פונה עקב אירוע חד פעמי של דם בשתן לפני שבוע, ללא כאבים או מחלת חום, ללא חבלה. בבדיקתו כעת: שתן כללי ותרבית תקינים, תפקודי כליות תקינים.

מהו המשך הברור המומלץ ?

א. CT Urography.

ב. סונר (US) כליות ודרכי שתן.

ג. אין צורך בבירור נוסף.

ד. שתן לציטולוגיה.

146. בן 60 אינו מסוגל ליישר את אצבעו ומרגיש שהיא ננעלת עם נקישה.

מהו הטיפול היעיל ביותר?

א. קיבוע של האצבע

ב. פיזיותרפיה

ג. טיפול בתכשירים אנטי דלקתיים

ד. ניתוח

בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021

שאלות שליליות:

147. בת 27, בריאה ללא שימוש בתרופות באופן קבוע. מזה שנתיים סובלת מהתקפים של כאבים באצבעות הידיים. ההתקף מתחיל מאצבעות בודדות ותוך זמן קצר מתפשט לכל האצבעות. בזמן התקף האצבעות מלבינות וכואבות, ולאחר מכן חוזרות לצבען הרגיל.

מה מהבאים **לא תומך** באבחנה הסבירה ביותר?

א. עישון של 10 סיגריות ליום מזה 8 שנים.

ב. ההתקפים תדירים יותר בתקופת לחץ נפשי.

ג. שתיית אלכוהול אקססיבית מביאה להתקף.

ד. סובלת מכאבי ראש מיגרנוטיים.

148. בן 76, שוחרר לאחר תיקון שבר בצוואר הירך. בבדיקתו - הצלקת הניתוחית תקינה, בקרסול שמאל - אודם עם התכייבות מרכזית שטחית ויבשה.

איזו מהפעולות הבאות **לא מומלצת** כטיפול למצבו?

א. שינוי תנוחה תדיר והנחיה לצאת כמה שיותר מהמיטה.

ב. חיטוי הפצע עם תמיסת יוד.

ג. שימון העור.

ד. דיאטה עשירה בחלבון.

149. בבדיקת שכיחות הסכרת במרפאתך מצאת כי השכיחות בבוגרים מגיל 20 ומעלה היא 3.5%. שכיחות הסכרת בישראל , בקבוצת גיל זו (20 ומעלה) על פי נתונים בינלאומיים מגיעה ל7.6% .

מה **אינו מהווה** הסבר סביר להבדל בשכיחות בין מרפאתך לנתונים הכלל-ארציים?

א. הגדרות הסכרת כפי ששימשו את הסקרים בכלל-ארציים היו ישנות.

ב. אוכלוסיית מרפאתך יחסית צעירה עם הרבה פחות בוגרים מגיל 45 ומעלה.

ג. הנתונים הכלל-ארציים התקבלו מסקרים טלפוניים, אנשים נוטים לייחס לעצמם מחלות שונות שלעתים אינן קיימות אצלם.

ד. במרפאתך קיים תת-אבחון של סכרת. חולים רבים טרם נתגלו.

<u>בחינת שלב ב' רפואת המשפחה 22.06.2021</u>

150. בן 68, ללא מחלות רקע. סובל מחום סיסטמי עד 39.4 במשך שבוע ימים. ללא תסמינים ממקדים למקור החום.

מה מהבאים **<u>לא</u>** יצדיק ביצוע תרביות דם?

א. גיל המטופל

ב. 18.000 WBC

ג. Creatinine 1.3

ד. לחץ דם סיסטולי מתחת ל-90 ממ"כ

בהצלחה!